



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Διπλωματική Εργασία:

**‘Περιορισμοί και δυνατότητες της δομής Στέκι 46 μέσα στο
υπάρχον κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο μέσα από την εμπειρία
των εργαζομένων’**

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΞΕΡΤΗΣΕΙΣ»

Επόπτης Καθηγητής: Γαζγαλίδης Κώστας

Ερευνήτρια: Δουμάνη Αθηνά

ΑΘΗΝΑ 2023-2024

Πρόλογος - Περίληψη

Με αφορμή την σχετικά πρόσφατη λειτουργία του πρώτου χώρου εποπτευόμενης χρήσης στην Ελλάδα, η παρούσα έρευνα επιδιώκει να κατανοήσει εις βάθος τις δυναμικές που προκύπτουν μέσα στο Στέκι 46, το οποίο δραστηριοποιείται στο σύγχρονο κοινωνικό - πολιτικό πλαίσιο της Αθήνας. Συγκεκριμένα, εστιάζοντας στην οπτική και στις εμπειρίες των εργαζομένων θα επιδιώξει να αποτυπώσει τις υπηρεσίες που παρέχουν, τις συνθήκες, στις οποίες καλούνται να παρέμβουν οι ίδιοι μέσα στα πλαίσια της δομής, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το προσωπικό αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν να συμβάλει στο δίκτυο δομών που απασχολείται με την υποστήριξη των εξαρτημένων ατόμων στην Αθήνα.

Στα πλαίσια, επομένως, αυτής της έρευνας θα γίνουν χρήση ποιοτικών εργαλείων και πιο συγκεκριμένα ημι-δομημένων συνεντεύξεων. Οι συμμετέχοντες θα είναι οι εργαζόμενοι της δομής, που καλύπτουν ποικίλες και ζωτικές θέσεις, με στόχο να προκύψει μια ολιστική προσέγγιση και μια πολύπλευρη κατανόηση του πλαισίου.

Περιεχόμενα

<i>Πρόλογος – Περίληψη</i>	2
<i>Περιεχόμενα</i>	3
<i>Εισαγωγή</i>	4
<i>Μεθοδολογία</i>	9
<i>Σχεδιασμός Έρευνας</i>	9
<i>Δειγματοληψία</i>	9
<i>Δημογραφικά Στοιχεία</i>	10
<i>Ανάλυση Δεδομένων</i>	10
<i>Περιορισμοί στην Έρευνα</i>	11
<i>Πλεονεκτήματα Έρευνας</i>	12
 <i>Κεφάλαιο 1</i>	
<i>Χώροι Εποπτευόμενης Χρήσης</i>	13
<i>Η Λειτουργία του Στέκι 46 και οι Διαδικασίες Παροχής Υπηρεσιών</i>	16
<i>Πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες στον Πληθυσμό της Αθήνας</i>	22
 <i>Κεφάλαιο 2</i>	
<i>Περιορισμοί στη Λειτουργία του Στέκι 46 σε σχέση με τη παροχή υπηρεσιών</i>	
<i>A. Κοινωνικοί- Οικονομικοί Περιορισμοί</i>	25
<i>B. Οργάνωση Δομής – Πιάτσα Πολυτελείας</i>	31
<i>Γ. Εργασιακή Κόπωση – Burnout</i>	36
 <i>Κεφάλαιο 3</i>	
<i>Προτάσεις Βελτίωσης των υπηρεσιών από τους εργαζόμενους/ εργαζόμενες</i>	
<i>A. Παροχή Υπηρεσιών</i>	40
<i>B. Συνθήκες Εργασίας</i>	44
<i>Συζήτηση – Συμπεράσματα</i>	45
<i>Παράρτημα – Συντομογραφίες</i>	52
<i>Βιβλιογραφία</i>	53

Εισαγωγή

Η ιστορία της αντιμετώπισης των ναρκωτικών παγκοσμίως χαρακτηρίζεται από έντονους διαλόγους, έρευνες και αντιφάσεις. Ο λόγος για αυτό είναι ότι η επιστήμη και η κοινωνία δεν έχει καταφέρει να απαντήσει ή τουλάχιστον να συμφωνήσει, ως προς τους παράγοντες που οδηγούνται τα υποκείμενα στη χρήση και την εξάρτηση. Το πρίσμα μέσα από το οποίο θα επιχειρήσει κάποιος ειδήμων να επεξεργαστεί το φαινόμενο της εξάρτησης οδηγεί σε διαφορετικές απαντήσεις και συνεπώς σε διαφορετικές προτάσεις για την αντιμετώπιση του. Η χρήση ουσιών ακολουθεί την ιστορία της ανθρωπότητας, μέσα από τελετές, διασκέδαση, κοινωνικές εκδηλώσεις. Όπως αναφέρει και ο Ν. Παρασκευόπουλος ‘για πολλούς αιώνες και σε όλες τις περιοχές του κόσμου η χρήση αυτή συνδεόταν με θεραπευτικές λειτουργίες, αλλά και με λατρευτικές συνήθειες, εκδηλώσεις πολιτισμού ή τελετουργίες’ (Παρασκευόπουλος Ν, 2004) Ωστόσο, στη νεωτερικότητα, όπως σημειώνει η Κ. Μάτσα «εγγράφεται στο κοινωνικό τοπίο, ως μια από τις πλέον αινιγματικές μορφές που παίρνει μια κατάσταση οριακή για τον άνθρωπο (Κ. Μάτσα, 2006). Η βιομηχανική επανάσταση, η εντατικοποίηση της εργασίας, η μετακίνηση πληθυσμών από τις αγροτικές περιοχές στις μεγαλουπόλεις, οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, η δημιουργία νέων φαρμακευτικών ουσιών, η μετανάστευση, η εφεύρεση της σύριγγας αποτέλεσαν ιστορικά γεγονότα που συνδέθηκαν με την αύξηση της χρήσης στον γενικό πληθυσμό και την εμφάνιση ενός νέου υποκειμένου, του ναρκομανή, με τη σύγχρονη έννοια. Η επιδείνωση της ποιότητας ζωής, συνδέεται με την αύξηση της ψυχικής δυσφορίας στον πληθυσμό και κατά συνέπεια και την αύξηση της χρήσης ουσιών. Χαρακτηριστικά η Κ. Μάτσα αναφέρει: ‘Κατά τη διάρκεια οικονομικών κρίσεων αυξάνεται το ποσοστό ψυχικών διαταραχών στο γενικό πληθυσμό, όπως και ο αριθμός των εισαγωγών στα ψυχιατρεία, ενώ μειώνονται τα ποσοστά κοινωνικής αποκατάστασης ψυχασθενών.’(Κ. Μάτσα, 2006) Σταδιακά αυτή η νέα τάξη πραγμάτων, οδήγησε στην δημιουργία νομοθετικών πλαισίων από τα διάφορα κράτη για τον έλεγχο της αγοράς των ουσιών και των πολιτών. Αντίστοιχα, αναπτύχθηκε ένα πεδίο κερδοφορίας όπου μεγάλες φαρμακευτικές, αλλά και έμπορες που κινούνται στη παρανομία, είδαν μια ευκαιρία για να αυξήσουν τα κέρδη τους.

Μέσα στα χρόνια, τα κράτη και η επιστημονική κοινότητα έχουν προτείνει ποικίλες μεθόδους και προγράμματα για την υποστήριξη των εξαρτημένων και την αντιμετώπιση των ναρκωτικών ως κοινωνικό φαινόμενο. Οι πολιτικές που αφορούν την θεραπεία της εξάρτησης και τη μείωση της κίνησης των ναρκωτικών σήμερα στην Ελλάδα ορίζονται από μια ευρωπαϊκή γραμμή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε να εφαρμόζει στρατηγικές για τα ναρκωτικά οι οποίες δεν δέσμευαν τα κράτη μέλη, αλλά ορίζουν κοινούς στόχους και προτεραιότητες. Οι τακτικές αυτές σε πολιτικό επίπεδο κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη στοχοθεσία της κάθε μιας. Υπάρχουν οι πολιτικές που επιδιώκουν τη μείωση ζήτησης των ναρκωτικών καθώς και των κινδύνων που μπορούν να επιφέρουν στην υγεία και την κοινωνία. Ένας δεύτερος πυλώνας της στρατηγικής αυτής στοχεύει στην διάρρηξη της παράνομης αγοράς των ναρκωτικών ουσιών όπως επίσης και στην ελάττωση της διαθεσιμότητας τους. Ενώ τέλος, κάποιες πολιτικές επικεντρώνονται στην ενίσχυση του δικτύου που συνδιαλέγετε πάνω στα ζητήματα των ναρκωτικών όπως επίσης και τη παρακολούθηση των εξελίξεων πάνω στο κλάδο. (Παπαρρηγόπουλος & Δάλλα, 2021).

Στην Ελλάδα η παρούσα εθνική πολιτική για τα ναρκωτικά προσδιορίζεται από το Νόμο 4139/2013. Στο ελλαδικό χώρο δραστηριοποιούνται δύο ειδών δομές. Υπάρχουν τα στεγνά προγράμματα που λειτουργούν χωρίς υποκατάστατα, όπου δίνεται προτεραιότητα στο θεραπευτικό πλαίσιο, εκεί λειτουργούν ομάδες ψυχοθεραπευτικού – ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα. Στόχος τους είναι ‘η διαδικασία διαρκών αλλαγών της προσωπικότητας και της στάσης ζωής αυτού του ατόμου, ικανό να αναλάβει τις ευθύνες του και να αντιμετωπίσει με θάρρος τη ζωή και τις δυσκολίες της’ (Κ. Μάτσα, 2006). Στα πλαίσια των στεγνών προγραμμάτων, τα μέλη των ομάδων αντιμετωπίζονται ως άτομα, στα οποία ‘μια ψυχολογική, προσωπική κρίση συναντήθηκε με μια κοινωνική’ (Κ.Μάτσα,2013). Παράλληλα, λειτουργούν προγράμματα απεξάρτησης με υποκατάστατα (μεθοδόνη, βουπρενορφίνη κτλ), που βάζουν ως προτεραιότητα τη λειτουργικότητα του ατόμου, τον έλεγχο της χρήσης, τη μείωση της βλάβης που προκαλείται από την κατανάλωση νοθευμένων ουσιών στο δρόμο και τη σταδιακή επανένταξη του υποκειμένου. Οι τελευταίες υιοθετούν μια πιο ιατρικό-κεντρική φιλοσοφία, όπου η εξάρτηση αντιμετωπίζεται ως ‘χρόνια υποτροπιάζουσα νόσο του εγκεφάλου’.

Παρά της διαφορετικές νοοτροπίες που υιοθετούν τα προγράμματα απεξάρτησης, όλα μαζί συνδράμουν στο να δημιουργηθεί ένα δίκτυο δομών που θα μπορέσει να προσεγγίσει και να ελέγξει τα πολλαπλά επίπεδα του φαινομένου των ναρκωτικών. Δυστυχώς, στην Ελλάδα, παρατηρείται διαρκώς αύξηση του πληθυσμού των χρηστών ουσιών. Η συνολική εικόνα που επικρατεί στην Αθήνα, με την δυσχερή οικονομική κατάσταση, με την αύξηση των αστέγων, την σταθερή παρουσία πολλών σημείων που λειτουργούν ως πιάτσα ναρκωτικών, την εκτόξευση του αριθμού των ατόμων που ζουν χωρίς χαρτιά στην πόλη, δημιουργεί ένα δυστοπικό τοπίο που συνδέεται άμεσα με την αύξηση της χρήσης ουσιών αλλά και των αντίστοιχων παράνομων δράσεων. Μεγάλα κοινωνικά γεγονότα, όπως η οικονομική κρίση του 2008, συνέβαλε επίσης στο να μειωθούν οι κρατικές δαπάνες στις δομές που ασχολούνται με την αντιμετώπιση των ναρκωτικών. Στην περίοδο της κρίσης παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση του ιού HIV στον πληθυσμό των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών (1600%), αφού προηγήθηκε μείωση της χρηματοδότησης για προληπτικές δράσεις αλλά και μείωση δράσεων ανταλλαγής συρίγγων στον πληθυσμό των χρηστών. (Τζίνη,2019-2019). Το 2013 στην Ελλάδα όλοι οι οργανισμοί απεξάρτησης και ΜΚΟ παρείχαν και αντάλλαζαν 429.517 σύριγγες έναντι 68.579 το 2009 ενώ μοιράστηκαν και 211.744 προφυλακτικά έναντι 74.184 προφυλακτικών το 2011. (Παπαδημητρίου,2014) Παρόλο που δεν υπάρχουν στατιστικά κάθε έτους για τη ζήτηση και παροχή συριγγών και γενικότερα εξοπλισμού ασφαλούς χρήσης, τα στατιστικά αυτά μας δίνουν μια εικόνα του μεγέθους του προβλήματος.

Οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζει ένας ενεργός χρήστης φθείρουν διαρκώς την κατάσταση της υγείας του, τόσο μέσω της χρήσης ουσιών που καταπονούν το ανθρώπινο σώμα φτάνοντας συχνά σε αναπηρικούς τραυματισμούς (κατάρρευση του φλεβικού συστήματος κτλ), όσο και από τις συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται η χρήσης (αστεγία, κοινόχρηστες σύριγγες κτλ). Η καθημερινότητα των εξαρτημένων χαρακτηρίζεται από κακή διατροφή, στιγματισμό, έλλειψη στέγης, παράνομες δραστηριότητες και έκθεση σε κινδύνους που αυτές επιφέρουν, δύσκολη πρόσβαση στις δομές του εθνικού συστήματος υγείας κτλ.). Η χρήση ναρκωτικών ουσιών αποτελούν ένα τεράστιο κίνδυνο για τον ίδιο το χρήστη, ωστόσο θα πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι αποτελούν μια απειλή συνολικά για τη δημόσια υγεία αλλά και για την κοινωνική ευημερία. Ένας στους τρεις χρήστες που είναι ενταγμένοι σε

κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα είναι φορέας του ιού HIV/AIDS και της ηπατίτιδας C. Ο μεγαλύτερος αριθμός των ατόμων που κάνει χρήση ΣΙΣΑ συνήθως δεν έχει καταφύγιο, έχει πολλά προβλήματα υγείας, και δεν λαμβάνει την κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση για την ασφαλή χρήση ουσιών και την ασφαλή σεξουαλική επαφή. Συνεπώς, είναι ανάγκη να δημιουργηθεί ένα πλάνο, μία μοναδική, κεντρική πολιτική με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος. (Τζίνη, 2018-2019) Κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα σημειώθηκε σημαντική αύξηση στα περιστατικά της λοίμωξης HIV. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ μεταξύ της περιόδου Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2011 δηλώθηκαν στο ΚΕΕΛΠΝΟ 803 περιπτώσεις HIV λοίμωξης εκ των οποίων οι 686 (85,43%) αφορούσαν σε άνδρες και οι 117 (14,57%) σε γυναίκες. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 η αύξηση το 2011 ανέρχεται στο 52,7% (ΚΕΕΛΠΝΟ, 2011). Επιπλέον, δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητη οι τυχόν εγκληματικές ενέργειες που συνδέονται με τη χρήση ουσιών (π.χ. κλοπές, βιαιοπραγίες, συμμορίες διακίνησης κτλ).

Παρατηρώντας αυτή την εικόνα, η οποία δυστυχώς είναι εμφανής παγκοσμίως, η κοινότητα επιστημών και ειδικών που δουλεύουν πάνω στην αντιμετώπιση των ναρκωτικών, εισήγαγε τη πολιτική μείωσης βλάβης. Η πολιτική αυτή δεν έχει ως στόχο την θεραπεία της εξάρτησης, αλλά προσπαθεί να λειτουργήσει ως ενδιάμεσο βήμα, που θα συμβάλει στον έλεγχο των παράπλευρων συνεπειών που έχει η χρήση ουσιών. Κάποιες από αυτές είναι η συντήρηση της υγείας των ναρκομανών, η πρόληψη των overdose, η διασύνδεση τους με το δημόσιο σύστημα υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες, η εξάλειψη των περιοχών πιάτσας, η παροχή καθαρών υλικών για χρήση (π.χ. σύριγγες) κτλ. ‘Ο όρος μείωση βλάβης (harm reduction) περιγράφει μια δέσμη μέτρων, στρατηγικών, πολιτικών, που αφορούν σε ομάδες πληθυσμού, που έχουν ως στόχο να μειώσουν τους κινδύνους και τις βλάβες που προκύπτουν από τις υψηλού κινδύνου συμπεριφορές τους. [...] Πρόκειται λοιπόν, για δέσμη μέτρων που βρίσκεται στον πυρήνα των πρακτικών για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας.’ (Κ. Γαζγαλίδης, 2005) Πάνω σε αυτή τη λογική λειτουργούν τα κέντρα υποκαταστάτων, οι χώροι εποπτευόμενοι χρήσης, οι ομάδες street work κ.α. Οι πρακτικές αυτές δεν χαρακτηρίζονται από το τι θα πρέπει να γίνει, μια στοχοθεσία για το μέλλον του ατόμου που κάνει χρήση και τη κοινωνία. Αντίθετα, παρεμβαίνει στο υπάρχον, σε αυτό που συμβαίνει στο παρόν και προσπαθούν να μειώσουν την επικινδυνότητα. ‘Οι

πρακτικές αυτές μπορούν να αντιπαρατεθούν με τα στεγνά προγράμματα τα οποία στοχεύουν στην αποχή και στην διακοπή της σχέσης του χρήστη με την ουσία. Αντίθετα τα προγράμματα μείωσης βλάβης προωθούν τη λογική ότι η αποχή καθώς και η διακοπή μπορεί να μην είναι ο στόχος κάποιου εξαρτημένου αλλά επικεντρώνονται στην βραχύχρονη διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη χρήση. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα προγράμματα αυτά δεν λειτουργούν αντιπαραθετικά, αντίθετα μπορούν σε μια λογική συνεργασίας να λειτουργήσουν συμπληρωματικά ώστε να επωφεληθούν τα υποκείμενα που απευθύνονται σε αυτά.' (James & Harrison, 2000) Με αυτόν τον τρόπο ο ίδιος ο χρήστης μπορεί να διατηρήσει μια σταθερή σωματική κατάσταση, και ίσως και ψυχολογική – ψυχιατρική, ώστε να μην συνεχίσει να παρακολουθεί τη ποιότητα ζωής του να επιδεινώνεται και βυθίζεται σε μια αδιέξοδη κατάσταση.

Η έρευνα αυτή επικεντρώνεται στη λογική και τις πρακτικές των χώρων εποπτευόμενης χρήσης, που λειτουργούν σε πολλές πόλεις της Ευρώπης και πρόσφατα, το 2022, άνοιξε και ο πρώτος στην Ελλάδα, με βάση την το κέντρο της Αθήνας.

Μεθοδολογία

Σχεδιασμός έρευνας

Για την παραγωγή των δεδομένων διεξήχθησαν 7 ημι-δομημένες συνεντεύξεις με εργαζόμενες/ους του χώρου εποπτευόμενης χρήσης 'Στέκι 46', που εντάσσεται στον OKANA. Για την ανάλυσή τους χρησιμοποιήθηκε η θεματική ανάλυση.

Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρειάστηκε η δημιουργία ενός πρωτοκόλλου δεοντολογίας, το οποίο έπειτα από βιβλιογραφική έρευνα και μελέτη συμπληρώθηκε και εγκρίθηκε από το τμήμα έρευνας και αξιολόγησης του OKANA. Τα ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν από την βιβλιογραφία αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία διαμορφώθηκαν ανοιχτού τύπου ερωτήσεις για τις συνεντεύξεις. Στη συνέχεια, η ερευνήτρια προχώρησε σε επικοινωνία και ενημέρωσης της συντονίστριας της δομής, η οποία αδειοδότησε την απασχόληση των εργαζομένων για τη συμμετοχή στις συνεντεύξεις. Μέσα από την τακτική παρουσία στο χώρο εποπτευόμενης χρήσης η ερευνήτρια πραγματοποίησε 7 συνεντεύξεις, με εργαζόμενους και εργαζόμενες που καλύπτουν ποικίλους ρόλους στη δομή. Σε όλους τους συμμετέχοντες παραχωρήθηκε φόρμα συγκατάθεσης και ενημερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας.

Δειγματοληψία

Στην έρευνα συμμετείχαν 7 άτομα, εκ των οποίων 3 γυναίκες και 4 άντρες, οι ηλικίες τους ποικίλουν με τη μικρότερη να είναι 27 και την μεγαλύτερη να είναι 47. Το ίδιο ισχύει και για το επάγγελμά τους, καθώς στόχος ήταν να αποτυπωθεί μια ολιστική αντίληψη πάνω στη λειτουργία του χώρου εποπτευόμενης χρήσης στην Αθήνα. Μοναδικό κριτήριο συμμετοχής στην έρευνα αποτελεί την εργασία στη δομή Στέκι 46. Ακολούθως, η επιλογή του δείγματος έγινε βάσει της δειγματοληψίας χιονοστιβάδας ή αλυσιδωτής δειγματοληψίας (Τσιώλης, 2014). Η συγκεκριμένη δειγματοληψία έγινε στη βάση, ότι υπήρξαν κάποια άτομα- κλειδιά, τα οποία θα μπορούσαν να δια φωτίσουν τις πολλαπλές πτυχές του υπό διερεύνηση ζητήματος τη έρευνας, μέσα από τη δική τους εμπειρία ως εργαζόμενοι-ες στο χώρο εποπτευόμενης χρήσης. Έτσι από τον πρώτο συνεντευξιαζόμενο ζητήθηκε να προτείνει κάποιο συνάδερφο ή συναδέρφισσα που θα μπορούσε να δια φωτίσει πτυχές του ρόλου και της λειτουργίας της δομής μέσα στο υπάρχον κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο. Κατ'

αυτόν τον τρόπο συμπληρώθηκε το δείγμα των συμμετεχόντων. Όλοι οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες ενημερώθηκαν για το κώδικα δεοντολογίας και υπέγραψαν τη φόρμα συγκατάθεσης, η οποία έχει διαμορφωθεί και εγκριθεί από τον ΟΚΑΝΑ.

Δημογραφικά στοιχεία

<i>Ψευδώνυμο</i>	<i>Ηλικία</i>	<i>Επάγγελμα</i>
Νίκος	32	Κοινωνιολόγος
Γιώργος	42	Κοινωνιολόγος
Μαρία	35	Νοσηλεύτρια
Κώστας	45	Φύλακας
Ελένη	27	Ψυχολόγος
Δήμητρα	29	Κοινωνική Λειτουργός
Στέφανος	47	Ψυχολόγος

*Τα ονόματα των συμμετεχόντων έχουν αντικατασταθεί από ψευδώνυμα για την διατήρηση του απορρήτου.

Ανάλυση δεδομένων

Όλες οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης. Η διάρκεια του ποικίλει και κυμαίνεται κατά προσέγγιση από 10 έως 20 λεπτά. Σκοπός της ερευνήτριας ήταν αρχικά οι συνεντεύξεις να διαρκούν από 20 λεπτά έως 1 ώρα, ωστόσο λόγω φόρτου εργασίας των συμμετεχόντων ο χρόνος των συνεντεύξεων μειώθηκε αναγκαστικά. Μετά την μεθοδική απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων ακολούθησε η συστηματική εξοικείωση με τα δεδομένα. Η ανάλυση έγινε σε 2 στάδια, όπου το πρώτο περιελάμβανε την κωδικοποίηση της κάθε ατομικής συνέντευξης από την συνεντεύκτρια, ενώ το δεύτερο την συμπύκνωση των κωδικών και την ανάδειξη

κοινών μοτίβων, στο σύνολο των συνεντεύξεων. Επιλέχθηκε η θεματική ανάλυση, προκειμένου να συγκροτηθούν οι συλλογικές αναπαραστάσεις εμπειριών των εργαζόμενων στον χώρο εποπτευόμενης χρήσης Στέκι 46. Έτσι, έγινε προσπάθεια να αναγνωριστούν και να συγκροτηθούν τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα νοήματος που υπήρχαν στις συνεντεύξεις. Σε αυτό το στάδιο, τα ερευνητικά ερωτήματα αποτέλεσαν την αρχή για τη διαδικασία παραγωγής των θεματικών ενοτήτων και των υποθεμάτων (Τσιώλης, 2017).

Περιορισμοί στην Έρευνα

Ένας από τους σημαντικούς περιορισμούς της έρευνας είναι ότι οι συνεντεύξεις διεξάχθηκαν μέσα στα χρονικά όρια της βάρδιας των εργαζομένων και στο χώρο εργασίας τους. Αυτός ο παράγοντας οδήγησε στη μείωση της χρονικής διάρκειας των συνεντεύξεων. Ενώ βάση πρωτοκόλλου η επιθυμητή διάρκεια των συνεντεύξεων ήταν από 20 λεπτά έως 1 ώρα, η διάρκεια τους εν τέλει ήταν από 10 λεπτά έως 20 λεπτά. Καθώς ο χρόνος που αφιέρωσαν για την συνέντευξη ήταν στα πλαίσια της εργασίας τους δεν μπόρεσαν, λόγω φόρτου εργασίας, να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο. Επιπλέον, ο χώρος μέσα στον οποίο διεξάχθηκαν οι συνεντεύξεις λειτούργησε ως περιορισμός για δύο λόγους. Αρχικά, σε δύο συνεντεύξεις δημιουργήθηκε η εντύπωση στην ερευνήτρια, ότι δεν μπορούν οι συμμετέχοντες να μιλήσουν ελεύθερα και δεν νιώθουν άνετα με κάποιες ερωτήσεις. Όπου και διακόπηκε η ροή των ερωτήσεων με σκοπό να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα τους. Ενώ δύο συνεντεύξεις διακόπηκαν από τη παρέμβαση κάποιου άλλου μέλους από το προσωπικό. Παρά τους περιορισμούς και τις προσαρμογές που έγιναν, η συστηματική εξοικείωση με τα δεδομένα και η εντατική και προσεκτική μελέτη τους, συνέβαλε στην εξαγωγή των θεματικών όπως παρουσιάζονται σε αυτό το κείμενο.

Πλεονεκτήματα Έρευνας

Ένα από τα πλεονεκτήματα της έρευνας, είναι το γεγονός ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν αντίστοιχη μελέτη, στο χώρο εποπτευόμενης χρήσης στην Αθήνα. Δεδομένου ότι το Στέκι 46, λειτουργεί μόλις δύο χρόνια, δεν υπάρχει συνολική αποτύπωση του έργου του, ακόμα. Επιπλέον, η επιλογή να ληφθούν συνεντεύξεις από εργαζόμενους και εργαζόμενες της δομής, συνέβαλε στο να αναδειχθούν σκέψεις και προβληματισμοί που παράγονται μέσα στο πεδίο δράσης, αναδεικνύοντας βιωματικές οπτικές των ζητημάτων που προκύπτουν. Εκτιμώ, ότι η ανάδειξη αυτών των οπτικών, είναι ζωτικής σημασίας, για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του χώρου, αλλά και για την ενίσχυση του διαλόγου της επιστημονικής κοινότητας πάνω στη μείωση της βλάβης. Τα εργαλεία της ποιοτικής έρευνας, βοήθησαν στο να αναδειχθεί μια ολιστική εικόνα της κατάστασης, και του εργασιακού βιώματος των συνεντευξιαζόμενων. Έτσι η συγκεκριμένη έρευνα προσφέρει πολλά δεδομένα για τη λειτουργία του Στεκιού 46 αλλά και των συνθηκών μέσα στις οποίες καλείται να εργαστεί το προσωπικό. Ευελπιστώ να συμβάλει μελλοντικά στον επιστημονικό διάλογο για τις εφαρμογές της μείωσης της βλάβης στην Ελλάδα.

Κεφάλαιο 1

Χώροι εποπτευόμενης χρήσης

Οι χώροι εποπτευόμενης χρήσης ξεκίνησαν να λειτουργούν πάνω στη λογική της μείωσης της βλάβης που προκαλείται από τη χρήση ουσιών. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται η χρήση ναρκωτικών στο δρόμο χαρακτηρίζεται από παράγοντες που θέτουν σε επιπλέον κίνδυνο την υγεία και την ζωή των εξαρτημένων ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, τα εξαρτημένα υποκείμενα είναι εκτεθειμένοι σε εξωτερικούς παράγοντες διαρκώς, κάνουν χρήση κοινό συριγγών και μέσων για να πάρουν την ουσία ενώ βιώνουν συνεχώς αυξημένα επίπεδα στρες. Οντας σε κατάσταση στέρησης πολλές φορές, οι αποφάσεις που μπορεί να πάρει ένα άτομο ως προς το τόπου που θα κάνει χρήση αλλά και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει, δεν λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες της ασφάλειας και της βασικής υγιεινής. Οι μολύνσεις από ηπατίτιδες B και C καθώς και από τον ιό του HIV, είναι μια μόνο πτυχή των κινδύνων που επιφυλάσσει η παράνομη χρήση στο δρόμο. Το ποσοστά των ηπατιτίδων στην Ευρώπη στους ενδοφλέβιους χρήστες φτάνουν τις τιμές του 20-40%, ενώ του AIDS φτάνουν στο 20%. ‘Το ότι τα ποσοστά της μόλυνσης από ηπατίτιδα B και AIDS στην Ελλάδα είναι πιο χαμηλά είναι άξιο μελέτης, αλλά όχι επαρκές προς εφησυχασμό στοιχείο.’ (Γαζγαλίδης, 2005). Η χρόνια χρήση ουσιών χωρίς ιατρική φροντίδα μπορεί να επιφέρει και άλλους κινδύνους, όπως καρδιοπάθειες, γάγγραινα, πνευμονοπάθειες, κατάρρευση του φλεβικού συστήματος, αναπηρικοί τραυματισμοί και άλλα. (Γαζγαλίδης, 2005).

Την δυσάρεστη εικόνα αυτή συμπληρώνουν τα ζητήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν πολλοί από τους χρήστες, καθώς το ποσοστό συννοσηρότητας (συνύπαρξη της εξάρτησης με ψυχιατρικά θέματα) που είναι αρκετά υψηλό. Η συνύπαρξη ψυχιατρικών ζητημάτων και εξάρτησης παρουσιάζεται συχνά στη βιβλιογραφία, ως ένα φαινόμενο υπό μελέτη. Η Κ. Μάτσα αναφέρει ‘Τα ποσοστά που αφορούν την επικράτηση κάποιας μορφής ψυχικής διαταραχής σε τοξικομανείς, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, είναι πολύ υψηλά. Κυμαίνονται, ανάλογα τον τύπο της διαταραχής από 20% μέχρι 90% Οι περισσότεροι βέβαια τοποθετούν το μέσο ποσοστό συννοσηρότητας μιας σοβαρής ψυχικής διαταραχής (σχιζοφρένεια, διπολική

διαταραχή, σοβαρή κατάθλιψη) γύρω στο 50%. (Κ. Μάτσα, 2006) Ωστόσο, γίνεται μια διάκριση στο παραπάνω βιβλίο, σε εμφάνιση ψυχιατρικών συμπτωμάτων λόγω της χρήσης και την ύπαρξη κάποια διαταραχής στο άτομο. Στους ανθρώπους που ζουν και κάνουν χρήση στο δρόμο τα ζητήματα αυτά είναι αρρύθμιστα και χωρίς ψυχιατρική παρακολούθηση, είτε πρόκειται για συμπτώματα είτε για διαταραχή. Το γεγονός αυτό επιδεινώνει τη κατάσταση τους και μειώνει τις πιθανότητες τους να φροντίσουν τον εαυτό τους. Οι ενεργοί χρήστες λόγω του κοινωνικού στιγματισμού και της περιθωριοποίησης που βιώνουν καθημερινά, αντιμετωπίζουν επιπλέον δυσκολίες όσον αφορά τη πρόσβαση τους στο δημόσιο σύστημα υγείας, σε στέγη αλλά και σε μια ολοκληρωμένη διατροφή. Τέλος, λόγω της συστηματικής περιθωριοποίησης που βιώνουν αυτά τα άτομα έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμπλακούν σε παράνομες δραστηριότητες, όπως κλοπές, πορνεία, διακίνηση κτλ. Όλα αυτά συμβαίνουν ώστε το άτομο να εξασφαλίσει την ουσία που χρειάζεται. *«Όσο, λοιπόν, «βαθαίνει» η εξάρτησης, όσο μειώνονται οι δυνατότητες για εξεύρεση με νόμιμο τρόπο των χρημάτων, όσο αυξάνεται η εμπλοκή με τη λεγόμενη δευτερογενή εγκληματικότητα, τόσο αυξάνει ο κίνδυνος και η εμπλοκή τελικά με τις λεγόμενες διωκτικές, δικαστικές και σωφρονιστικές αρχές.» (Γαζγαλίδης, 2005)* Έτσι δημιουργήθηκε η λογική ότι πρέπει η παρέμβαση να γίνει στη πρώτη γραμμή και να παρέμβει στη καθημερινότητα των ενεργών χρηστών, για τη μείωση των μολύνσεων αλλά και των εγκληματικών ενεργειών που προκύπτουν από τη χρήση. *‘Οι υπηρεσίες πρέπει να φτάνουν στον χρήστη αντί να ρίχνουμε τις ευθύνες στον χρήστη για το αν αλληλεπιδρά με τις υπηρεσίες. Οι χρήστες στιγματίζονται αδίκως για το ότι δεν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες όταν και όπου αυτές υπάρχουν. Η εξάρτηση από ναρκωτικά δεν είναι απλώς θέμα βούλησης, σχετικά με το αν οι άνθρωποι θα σταματήσουν να παίρνουν ένα ναρκωτικό’ (Fortson & McCulloch, 2018)*

Οι χώροι εποπτευόμενης χρήσης, όπως και το street work, απευθύνεται σε αυτόν τον πληθυσμό. Μέσα από τη παροχή υπηρεσιών επιδιώκουν να βελτιώσουν τις συνθήκες μέσα στις οποίες γίνεται η χρήση και να λειτουργήσουν ως κρίκος μεταξύ των ατόμων αυτών και τις υπόλοιπες κοινωνίας καθώς επίσης και να πλαισιώσουν τις δραστηριότητες αυτών των ατόμων ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει για το κοινωνικό σύνολο η διακίνηση και χρήση ουσιών στο δρόμο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και τον Εθισμό, ο πρώτος χώρος ελεγχόμενης χρήσης άνοιξε στην Βέρνη, στην Ελβετία τον Ιούνιο του 1986. Το παράδειγμα αυτό ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια και άλλες χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ισπανία, η Νορβηγία, το Λουξεμβούργο, η Δανία, η Ελλάδα και η Γαλλία. Οι δομές αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενεργούς χρήστες και παρόλο που οι υπηρεσίες που παρέχουν μπορεί να διαφοροποιούνται, συμπλέουν προς μια κοινή στοχοθεσία. Η εμφάνιση των δομών αυτών συνδέεται με την επιδημία του AIDS, τη δεκαετία του '80, όπου άρχισε να γίνεται κατανοητό ότι η αντιμετώπιση των ναρκωτικών χρειάζεται μια πληθώρα διαφορετικών παρεμβάσεων και δομών. Αρχικά, οι υπηρεσίες μείωσης βλάβης επικεντρώθηκαν στη διεύρυνση της πρόσβασης σε θεραπεία απεξάρτησης με αγωνιστές των οπιοειδών και προγράμματα παροχής καθαρών συριγγών, κυρίως ως μέρος της αντίδρασης στη χρήση ναρκωτικών υψηλού κινδύνου, με κύριο στόχο τους ενδοφλέβιους χρήστες και την επιδημία HIV/AIDS. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι προσεγγίσεις για τη μείωση των βλαβών έχουν διευρυνθεί σε ορισμένες χώρες της ΕΕ για να περιλάβουν και άλλες παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων επίβλεψης δωματίων κατανάλωσης ναρκωτικών και προγραμμάτων λήψης ναλοξόνης για τη μείωση των θανατηφόρων υπερδοσολογιών. Σε ορισμένες χώρες υπάρχουν επίσης εγκαταστάσεις έλεγχου ναρκωτικών, που έχουν στηθεί για να επιτρέπουν στους ανθρώπους να ελέγχουν τη ποιότητα και τη καθαρότητα των ουσιών που έχουν αγοράσει. (EMCDDA, 2023)

Σήμερα, οι υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως στους χώρους εποπτευόμενης χρήσης είναι η παρέμβαση σε περίπτωση overdose, παροχή καθαρού εξοπλισμού, πρόσβαση σε ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες και σε κάποια κέντρα και ψυχιατρικές, παροχή φαγητού και νερού, πρόσβαση σε μπάνιο, διασύνδεση με άλλες δομές όπως ξενώνες και κέντρο απεξάρτησης και άλλα πολλά. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοντέλο το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα πλαίσια, αντίθετα κάθε χώρα προσαρμόζει τις πολιτικές και πρακτικές της ανάλογα με τις συνθήκες και τα προβλήματα που προκύπτουν. (Fortson & McCulloch, 2018). Τα κέντρα εποπτευόμενης χρήσης σε αντίθεση με το street work, δεν παρεμβαίνουν μέσα στη πιάτσα, δηλαδή στο δρόμο. Αντίθετα, προσφέρουν ένα άλλο, οριοθετημένο πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται ο χρήστης να μπει, εφόσον το επιλέξει, και να σεβαστεί τους κανόνες και τη λειτουργία του. Σημαντική είναι η ύπαρξη ιατρικού

εξοπλισμού στο χώρο, που μπορεί να αυξήσει της πιθανότητες επιτυχίας σε μια παρέμβαση σε overdose, καρδιακή ανακοπή, επικινδύνους τραυματισμούς κ.α.

Το προσωπικό μέσα σε ένα χώρο εποπτευόμενης χρήσης, συνήθως αποτελείται από γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς και περιπτώσεις ενεργών χρηστών που μπορούν να ανταπεξέλθουν στο βάρος που φέρει ένας τέτοιος ρόλος. (Γαζγαλίδης, 2008) Οι επαγγελματίες που αφορούν τη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και ενδυνάμωση, στοχεύουν στην διασύνδεση των εξυπηρετούμενων με δομές ανεξάρτησης ή ξενώνες αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος αυτοφροντίδας και αυτοβοήθειας που έχει ο κάθε χρήστης μέσα του. Σημαντική είναι η τοποθεσία του χώρου, αφού στόχος είναι να βρίσκεται κοντά σε σημεία διακίνησης ουσιών.

Όπως αναφέρει ο Κ Γαζγαλίδης, το 1995 στη Ζυρίχη λειτούργησαν χώροι εποπτευόμενης χρήσης, τους οποίους ένα μικρό ποσοστό των ενεργών χρηστών επέλεξε να χρησιμοποιήσει. Ωστόσο, μέσα σε διάστημα 2 χρόνων, χρησιμοποίησαν τους χώρους 135.000 άνθρωποι αλλά χρειάστηκε να γίνει παρέμβασης ανάνηψης μόνο στο 0.05% των περιστατικών, ενώ το ιατρικό προσωπικό περιπολήθηκε 6.000 αποστήματα, και κάποιοι χρήστες κινητοποιήθηκαν να επισκεφτούν φορείς δημόσιας υγείας για πιο σύνθετα προβλήματα. (Γαζγαλίδης, 2008).

Η λειτουργία του Στέκι 46 και οι διαδικασίες παροχής υπηρεσιών

Ο χώρος εποπτευόμενης χρήσης που λειτούργησε στην Αθήνα με απόφαση του ΦΕΚ 1607/Β/27-4-2020, συμπλέει στην ίδια λογική και φιλοσοφία. Σύμφωνα, με το καταστατικό ίδρυσης του λειτουργεί καθημερινά 8:00 με 20:00, διαθέτει 12 θέσεις για ενέσιμη και μη χρήση ουσιών και στελεχώνεται από μια μικτή διεπιστημονική ομάδα 30 ατόμων. Η θέση του κτηρίου βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας (Καποδιστρίου 46), μια περιοχή όπου οι πιάτσες ναρκωτικών έχουν γίνει κανονικότητα τα τελευταία χρόνια. Όπως αναφέρετε και στη βιβλιογραφία, προβλέπετε ότι οι χώροι αυτοί θα πρέπει να λειτουργούν σε περιοχές με αυξημένη δημόσια χρήση ουσιών και όχι απαραίτητα σε κάθε πόλη. (Fortson & McCulloch, 2018) Το γεγονός ότι στο κτήριο λειτουργεί και Σταθμός Φροντίδας Εξαρτημένων

Ατόμων (ΣΦΕΑ), αρκετά χρόνια πριν ανοίξει το ΧΕΧ (Χώρος Εποπτευόμενης Χρήσης), συνέβαλε στην γρήγορη ενημέρωση των εξαρτημένων ατόμων της περιοχής, αλλά και στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών και συνεννόησης των ομάδων των εργαζομένων (street work, ΣΦΕΑ, ΧΕΧ).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Στέκι 46, είναι ο πρώτος χώρος εποπτευόμενης χρήσης που λειτουργεί στην Ελλάδα, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετήσουμε τη λειτουργία του και τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να αντιμετωπίσει μέσα στο συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο. Ωστόσο, λόγω του γεγονότος ότι προσφέρει τις υπηρεσίες του μόνο τα τελευταία 2 χρόνια, δεν υπάρχουν στατιστικά δεδομένα για τη δομή αυτή. Μέσα από τις συνεντεύξεις προέκυψε ότι τώρα οι εργαζόμενοι βρίσκονται στην διαδικασία δημιουργίας μια βάσης δεδομένων η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των υπηρεσιών της δομής αλλά και για μελλοντικές έρευνες και μελέτες. *‘ασχολούμαστε πολύ το τελευταίο διάστημα με την ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει ο χώρος εποπτευόμενης χρήσης, που περνάνε όλα τα δεδομένα των ατόμων εδώ που εξυπηρετούμε, που κάνουν χρήση αλλά και τι υπηρεσίες από εμάς παίρνουν’* (Ελένη, 27). Ωστόσο άτυπα, χωρίς να υπάρχουν επίσημα στατιστικά δεδομένα, η Μαρία νοσηλεύτρια του ΧΕΧ, αναφέρει *‘δηλαδή συνολικά από το '22 μέχρι και το τέλος του '23, είχαμε συνολικά κοντά στις 50.000 επισκέψεις. όπου ήταν και για χρήση αλλά και για ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες.’* (Μαρία, 35). Γίνεται εμφανές, επομένως, από την προσέγγιση των ενεργών χρηστών, η ανάγκη του πληθυσμού για την ύπαρξη τέτοιων χώρων, που θα παρεμβαίνουν στη πρώτη γραμμή και θα παρέχει άμεση βοήθεια.

Οι υπηρεσίες που παρέχει ο χώρος εποπτευόμενης χρήσης στην Αθήνα, δεν διαφέρει σημαντικά από αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Εξετάζοντας αρχικά, τις υποχρεώσεις και το κόστος των κοινωνικών λειτουργών και των ψυχολόγων, αναφέρονται τα παρακάτω: *‘πρώτη μας δουλειά είναι η επίβλεψη της χρήσης... εεε.. μιλάμε με τους ανθρώπους, τους προσεγγίζουμε, κάνουμε συνεδρίες, έτσι, συμβουλευτικής, αποφόρτισης, κάνουμε συνοδείες σε δημόσιες υπηρεσίες, σε νοσοκομεία άμα έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας... ε.... διασύνδεση με υπηρεσίες, αυτά κατά κύριο λόγο (Νίκος, 32).* Η διαδικασία που ακολουθείτε με την είσοδο ενός νέου μέλους στο χώρο είναι η ακόλουθη: *‘με το που έρχεται ένα άνθρωπος εδώ πέρα του*

παίρνουμε ένα σύντομο κοινωνικό ιστορικό, στο οποίο καταγράφονται όλες οι ανάγκες του, συνθήκες στέγασης, οικογενειακή κατάσταση, όνομα επώνυμο, ΑΜΚΑ αν τυχόν έχει, κάποιο νομικό έγγραφο πχ ταυτότητα... οτιδήποτε, αποφυλακιστήριο οτιδήποτε το οποία έχει πάνω του, ή θα ήθελα και εκείνος να του το βγάλουμε να τον βοηθήσουμε' (Μαρία,35) Το ψυχοκοινωνικό προσωπικό, ασχολείται κυρίως με τις παραπάνω διαδικασίες, ενώ παράλληλα προσεγγίζουν τους χρήστες, παίρνουν κοινωνικό ιστορικό και προσπαθώντας να χτίσουν διαπροσωπικές σχέσεις με άτομα, που ενδεχομένως επιθυμούν να συμμετέχουν σε κάποια ατομική συνεδρία ή να προχωρήσουν σταδιακά σε προγράμματα απεξάρτησης. 'Σε κάποια στιγμή, στους πρώτους μήνες, είχε ειπωθεί από την προϊσταμένη ότι πρέπει να έχουμε ανθρώπους συγκεκριμένους που πρέπει να μιλάμε εμείς. Δηλαδή ατομικά' (Δήμητρα,29). Η παραπάνω διατύπωση μας δείχνει τη λογική πάνω στην οποία έχει καλεστεί να εργαστεί το προσωπικό, και ιδιαίτερα οι ψυχοκοινωνικές ειδικότητες. Σε δεύτερο στάδιο επομένως, αφού έχει ολοκληρωθεί το κοινωνικό ιστορικό, υπάρχει προσπάθεια να δεσμεύουν οι ωφελοούμενοι σε μια σταθερή επικοινωνία με το προσωπικό, να χτιστεί μια προσωπική σχέση, μέσα από την οποία ενδεχομένως να μπορέσει να υπάρξει ενδυνάμωση και επιθυμία ένταξης σε ένα νέο πλαίσιο. Επιπλέον, η διαδικασία αυτή, εφόσον υπάρξει διάρκεια, συμβάλει σταδιακά στην ενίσχυση της συνέπειας σε βασικές καθημερινές ανάγκες, οι οποίες στο πλαίσιο του δρόμου παραμελούνται (φροντίδα υγιεινής, συνέπεια σε φαρμακευτικές αγωγές κτλ). Θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι οι άνθρωποι που μένουν στη δρόμο συνήθως δεν έχουν κάποιο σταθερό πλαίσιο στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν για βασικές τους ανάγκες, ακόμα και για μια απλή συζήτηση. 'μία από αυτούς τώρα ας πούμε, που.. είναι τώρα στη φυλακή τώρα μια χρήστρια, το γεγονός ότι παίρνει τηλέφωνο κάθε απόγευμα σχεδόν εδώ, και απλά μιλάμε.. τι κάνει και αυτά, πως είναι εκεί... θέλει κάπου να πει τα νέα της και είμαστε εμείς εδώ οι άνθρωποι που σκέφτεται να το κάνει αυτό το μοίρασμα, είναι πολύ σημαντικό' (Δήμητρα, 29) Το προσωπικό του χώρου εποπτευόμενης χρήσης, δουλεύει προς αυτή τη κατεύθυνση καθημερινά και μέσα από της συνεντεύξεις αναφέρονται κάποια παραδείγματα που επιβεβαιώνουν τη προσήλωση στη στοχοθεσία αυτή.

Στα πλαίσια επίσης, της ψυχοκοινωνικής παρέμβασης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην διασύνδεση των ατόμων με κρατικές υπηρεσίες όπως είναι επιδόματα, ξενώνες

φιλοξενίας, επισκέψεις σε γιατρούς κτλ. 'γενικά όλα τα κοινωνικό-προνοιακά που... σχεδόν έχουμε κάθε μέρα τέτοια αιτήματα [...] Δηλαδή στα κοινωνικό-προνοιακά θα ενδιαφερθούν γιατί τους καίει. Για ταυτότητα, χαρτιά, αν είναι πρόσφυγες, μετανάστες κτλ.' (Ελένη, 27) Σε όλες τις συνεντεύξεις αναφέρθηκαν τα αιτήματα για γραφειοκρατικά ζητήματα, όπως χαρτιά αποφυλάκισης, έκδοση ταυτοτήτων κτλ. Η ζωή στο δρόμο συνδέεται άμεσα με συχνή απώλεια χαρτιών, λόγω κλοπών αλλά και απώλειας σε μη νηφάλια κατάσταση.

Μια από τις βασικές υπηρεσίες του χώρου εποπτευόμενης χρήσης είναι οι ιατροκό-νοσηλευτικές παροχές. '...ανά πάσα στιγμή θα παρέμβουν όταν υπάρχει θέμα υπερδοσολογίας ή επίσης θεραπείας τραυμάτων. Υπό αυτήν την έννοια είναι μια προτεραιότητα και αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται στήριξη ανά πάσα στιγμή γιατί είναι εκτεθειμένοι σε μολύνσεις, σε κινδύνους τέτοιου είδους ή ναλοζόνης, αν και εφόσον υπάρχει υπερδοσολογία.' (Στέφανος, 47) Οι γιατροί και οι νοσηλευτές-υπηρεσίες, βρίσκονται συνεχώς σε εγρήγορση καθώς τα αιτήματα για σωματική φροντίδα είναι διαρκή. Πέρα από τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση, όπως είναι το overdose, που αναφέρετε παραπάνω, η ζωή στο δρόμο συνδέεται με συνεχή έκθεση σε βία και τραυματισμούς οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις δυστυχώς μένουν αφρόντιστοι.

Όταν ένας άνθρωπος έρχεται στην μονάδα του Στέκι 46, η διαδικασία που ακολουθείτε σε ιατρικό πλαίσιο είναι η ακόλουθη, σύμφωνα με τη συνέντευξη της νοσηλεύτριας Μαρίας 'όταν μετά τελειώσει το κοινωνικό ιστορικό μετά έρχεται στη νοσηλευτική και παίρνουμε ένα ιατρικό ιστορικό, αν έχει κάποια σοβαρή πάθηση, αν έχει κάνει χειρουργεία, αν έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα ή σε κανονικό νοσοκομείο... κάποιο άλλο παθολογικό ή ψυχιατρικό νόσημα που μπορεί να έχει... πάντα η συμπλήρωση του ιατρικού ιστορικού γίνεται πάντα κατά δήλωση των ωφελούμενων. Δηλαδή.. αν έχει ο ίδιος... αν έχει, ο ίδιος αν γνωρίζει ότι έχει κάτι, πράγματα τα οποία τα ξέρει ο ίδιος. Βέβαια, μπορεί και να γνωρίζει και να μην θέλει να το εκδηλώσει. Παρόλα αυτά σε κάθε περίπτωση πρέπει να συμπληρώσουμε το ερωτηματολόγιο... το ιστορικό του ανάλογα με το τι θα μας πει ο ίδιος. ε... όταν τελειώσει και με το ιατρικό ιστορικό κάνουμε μια καταγραφή των ζωτικών του σημείων, παίρνουμε πίεση, θερμοκρασία, σφίξεις ε.. και ο γιατρός ή ανάλογα και ο

νοσηλευτής μπορεί να κρίνει αν θα είναι κατάλληλος να κάνει χρήση ή όχι σε εκείνη την φάση.' (Μαρία, 35). Με την είσοδο στο χώρο λοιπόν, οι εργαζόμενοι-ες φροντίζουν να δημιουργηθεί μια κοινωνική και κλινική εικόνα για το άτομο που θέλει να κάνει χρήση των υπηρεσιών του χώρου. Η διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς μπορεί να αξιολογηθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο χρήστης αλλά και οι ανάγκες του έτσι ώστε να γίνει προσωποποιημένη προσέγγιση στο κάθε άτομο ξεχωριστά και σε ιατρικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Έπειτα, σε κάθε επόμενη επίσκεψη, θερμομετριούνται εξ αρχής, ώστε να υπάρχει εποπτεία της διαδικασίας και να αποφευχθούν περιστατικά υπερδοσολογίας, ενώ παράλληλα υπάρχει διαρκώς επιτήρηση του χώρου από το ψυχοκοινωνικό προσωπικό για τυχόν απρόοπτα περιστατικά.

Μια σημαντική υπηρεσία που παρέχετε επίσης, είναι η φύλαξη των φαρμακευτικών αγωγών που μπορεί να λαμβάνουν κάποια άτομα. *‘στην ιατρονοσηλευτική κρατάμε και φάρμακα, πάρα πολλών ανθρώπων που είναι άστεγοι και .. επειδή τους κλέβουμε και τους χτυπάνε καθημερινά, σε καθημερινή βάση, τους δίνουμε τη δυνατότητα να έρχονται και να αφήνουν τα φάρμακά τους και να έρχονται καθημερινά την αγωγή τους. Η όποτε είναι να τον πάρουνε τέλος πάντων. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ και αυτούς και εμάς. Τουλάχιστον να... να βλέπουμε κάθε... η συχνότητα που έρχονται στον χώρο ε... κρατάμε πολλά, πάρα πολλά φάρμακα. [...]Τους δίνουμε και αυτή τη δυνατότητα, είναι πολύ σημαντικό γ' αυτούς. Ότι τα έχουν κάπου ασφαλή και δεν θα με κλέψουμε να μου τα πάρουνε.'* (Μαρία, 35) Η δυνατότητα αυτή, είναι πολύ βοηθητική για τους χρήστες, όπως αναφέρετε και παραπάνω, καθώς τους παρέχει μια ασφάλεια, η οποία δυστυχώς στα πλαίσια της ζωής του δρόμου δεν ενδείκνυται, ενώ παράλληλα δεσμεύει τους λήπτες υπηρεσιών να επισκέπτονται σταθερά τη δομή και να χτίζουν μια επικοινωνία και σχέση εμπιστοσύνης με το προσωπικό.

Εξίσου ζωτικής σημασίας είναι και οι υπηρεσίες διασύνδεσης που παρέχονται καθημερινά στο χώρο εποπτευόμενης χρήσης της Αθήνας. *‘έχουμε κάνει πολλές διασυνδέσεις σε προγράμματα [...]δηλαδή αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι η διασύνδεση και το να φύγουνε από το ΧΕΧ, δεν είναι το έρχομαι, πίνω, φεύγω. Αυτό το έκανε και πριν φτιαχτεί το ΧΕΧ. Ο σκοπός είναι να φροντιστεί ολιστικά όσο γίνεται, να του βρεις έναν ξενώνα, να του δώσεις τα φάρμακά του'* (Μαρία, 35) Το ψυχοκοινωνικό

προσωπικό και κυρίως οι κοινωνικοί λειτουργοί, αναλαμβάνουν το κόστος του να διεκπεραιώσουν τα αιτήματα των ωφελούμενων για διασύνδεση με άλλες δομές. Οι διασυνδέσεις μπορεί να αφορούν ξενώνες φιλοξενίας αστέγων, αιτήματα για εξασφάλιση εγγράφων (όπως ταυτότητες, ΑΜΚΑ, αποφυλακιστήρια κ.α.) μπορεί να αφορούν αιτήσεις για επιδόματα, ραντεβού σε νοσοκομεία ή και άλλους κρατικούς φορείς ή ακόμα και αίτημα να ενταχθεί κάποιο άτομο σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Επιπλέον, εφόσον χρειαστεί το προσωπικό έχει τη δυνατότητα να κάνει και συνοδείες σε κάποια από τις παραπάνω υπηρεσίες. *‘Εμείς θα τον υποστηρίξουμε, θα τον παραπέμψουμε σε μια συνεργαζόμενη... οργάνωση που μπορεί να τον υποστηρίξει σε αυτό. Στην συνέχεια θα γυρίσει πίσω ή θα τον κάνουμε συνοδεία. Θα εξασφαλίσουμε παράβολο, φωτογραφίες, το χρηματικό ποσό τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες και θα του εκδώσουμε το παράβολο, θα τον πάμε συνοδεία και στο αστυνομικό τμήμα κάποιες φορές. Και εμείς από εδώ αλλά και σε συνεργασία με την ομάδα streetwork. Άρα το αποτέλεσμα θα είναι η έκδοση ταυτότητας ή κάποιος μπορεί να έχει χάσει το αποφυλακιστήριο του, να ήταν φυλακή. Μας καταθέτει ένα αίτημα εγγράφως, το στέλνουμε εμείς στη φυλακή υπηρεσιακώς, και εξασφαλίζουμε το αποφυλακιστήριο του. Κάποιος μπορεί να είναι οροθετικός και να μην είναι διασυνδεδεμένος με κάποια μονάδα ειδικών λοιμώξεων, να μην έχει πάει ποτέ ή να είναι lost στην μονάδα ειδικών λοιμώξεων, δηλαδή να πήγαινε και να, ξαφνικά να έμεινε εκτός θεραπείας. Φροντίζουμε να τον διασυνδέσουμε εκ νέου. Να τον επανεντάξουμε στην θεραπεία. Κάποιος μπορεί να έχει κάποια ψυχιατρικά θέματα να τον παρακολουθεί ψυχίατρος ή να μην τον έχει παρακολουθήσει ποτέ ψυχίατρος, θα τον συνδέσουμε άμεσα ή με τον ψυχίατρο τον δικό μας, ή αν είναι σε οξεία κατάσταση να τον πάμε συνοδεία στο ψυχιατρείο’* (Γιώργος,45) Αυτά είναι κάποια παραδείγματα που αναφέρθηκαν σε σχέση με τις υπηρεσίες διασύνδεσης.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούμε στην ανάγκη που υπάρχει το προσωπικό του χώρου εποπτευόμενης χρήσης να λειτουργεί ομαδικά. *‘η δουλειά είναι ομαδική, ο ένας επαγγελματίας συμπληρώνει τον άλλον επαγγελματία, ανεξαρτήτως ειδικότητας [...]Προσπαθούμε. Κάθε φορά που υπάρχει κάποια ανάγκη, κάποιο αίτημα λειτουργούμε ομαδικά, αυτό ισχύει και χρειάζεται να λειτουργούμε ομαδικά για την ικανοποίηση της ανάγκης ή των αναγκών τους’* (Γιώργος,45) Η ανάγκη αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι κάθε ωφελούμενος είναι ένα άτομο με πολλαπλές

ανάγκες και επομένως θα χρειαστεί συνεργασία και συνεννόηση για να καλυφτούν ολιστικά όλες. Κάθε άτομο που κάνει χρήση της δομής μπορεί να προσεγγίσει διαφορετικά άτομα από το προσωπικό και να αποκαλύψει διαφορετικά αιτήματα. Επιπλέον, κάθε ειδικότητα ή κάθε επαγγελματίας επίσης μπορεί να προτείνει ποικίλες λύσεις σε ένα πρόβλημα ή διαφορετικές προσεγγίσεις. Λόγο αυτής της διαδικασίας ο Γιώργος αναφέρει *‘Ο καθένας είναι μια μονάδα, ως επαγγελματίας. Απλά δεν εργάζεται μόνος του εργάζεται με ένα σύνολο επαγγελματιών άρα είναι σημαντικές όλες.. όλοι οι προβληματισμοί όλες οι προτάσεις, που έχει να καταθέσει ο καθένας από εμάς στα πλαίσια της ομάδας. Δεν μπορεί να δουλεύει καθένας από μόνος τους.’* (Γιώργος, 45)

Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι παρόλο που το Στέκι 46, δεν λειτουργεί μεγάλο χρονικό διάστημα έχει εξοπλιστεί ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίσουν έγκαιρα καταστάσεις κρίσης. *‘έχουμε πάρα πολύ καλό εξοπλισμό. Scanner φλεβών, καρδιογράφο, ο γιατρός μας που είναι ο ένας είναι αναισθησιολόγος έχει τη δυνατότητα να διασωληνώσει. Δηλαδή έχουμε δυνατότητες να κάνουμε πράγματα.’* (Μαρία, 35). Επομένως προκύπτει μέσα από τα λεγόμενα του προσωπικού ότι η δομή έχει όλα τα φώτα να λειτουργήσει αποτελεσματικά, στην πρώτη γραμμή της μείωσης βλάβης. Ωστόσο, όπως είναι αναμενόμενο σε όλες της δομές παροχής υπηρεσιών υπάρχουν και περιορισμοί, που προκύπτουν σε πολλά επίπεδα και θα πρέπει να τους εξετάσουμε με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της μονάδας.

Πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες στο πληθυσμό της Αθήνας

Στη προσπάθεια να καταγράψουμε τις υπηρεσίες και τον τρόπο λειτουργίας του Στέκιου 46, προέκυψαν μέσα από τις συνεντεύξεις κάποιες ιδιαιτερότητες στο πληθυσμό που απευθύνεται σε αυτό. Τα αιτήματα του πληθυσμού, ανέδειξαν τη ανάγκη για διαμόρφωση των υπηρεσιών ώστε να εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα. Μια βασική διαφορά στο πληθυσμό των ενεργών χρηστών της Αθήνας είναι ότι αποτελείται σε σημαντικό ποσοστό από άτομα χωρίς άδεια παραμονής στην χώρα. Η αύξηση του πληθυσμού των μεταναστών που κάνουν

χρήση, δημιουργεί κάποιες επιπλέον απαιτήσεις στη διαχείριση τους. Δεδομένου ότι πρόκειται για έναν πληθυσμό επιπλέον επιβαρυνμένο, σε μεγάλο ποσοστό δεν έχει χαρτιά, δεν έχει πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας και αντιμετωπίζει συχνά και τον περιορισμό της γλώσσας. *‘Καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος που είναι αλλοδαπός, χωρίς χαρτιά, χωρίς.. περιορισμένη η πρόσβασή του στο... εθνικό σύστημα υγείας. Θα χρειαστεί να κάνει κάποιες εξετάσεις ενδεχομένως, θα χρειαστεί κάποια νοσηλεία, εφόσον δεν είναι οξεία η κατάστασή του, θα χρειαστεί να πας, σε ένα γιατρό σε ένα... στα πλαίσια του ΕΣΥ, δεν θα μπορούσε να του συνταγογραφήσει χωρίς ΑΜΚΑ φαρμακευτική αγωγή. Καταλαβαίνετε τι δυσκολία υπάρχει; ...κάποιες εξετάσεις. Που θα κάνει αυτές τις εξετάσεις; Εφόσον δεν είναι συνταγογραφούμενες. Ποιος θα αναλάβει το κόστος των εξετάσεων;’* (Γιώργος,45) Οι εργαζόμενοι του χώρου εποπτευόμενης χρήσης, αναλαμβάνουν συχνά το βάρος να καλύψουν οι ίδιοι όποια ιατρικά ζητήματα προκύπτουν σε αυτό το πληθυσμό, πάντα μέσα στα όρια των δυνατοτήτων τους, ή να τους παραπέμψουν και τους συνοδέψουν όπου χρειάζεται. Σε άλλη συνέντευξη αναφέρεται: *‘αν δεν έχουν ΑΜΚΑ είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί θα πρέπει να δώσουνε και ένα μερίδιο, το οποίο ποτέ δεν διαθέτουν, ακόμα και αν είναι 4 ευρώ μόνο’* (Ελένη, 27) Γίνεται εμφανές, ότι τα αιτήματα αυτά προκύπτουν καθημερινά, ενώ όταν πρόκειται για μετανάστες ή μετανάστριες η διαδικασία δυσκολεύει, καθώς θα πρέπει να πληρώσουν τα ίδια τα άτομα για τις εξετάσεις τους, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο για άτομο που μένουν στο δρόμο, δεν έχουν εισόδημα και κάνουν χρήση. Η αύξηση των μεταναστών-στρίων στην Αθήνα, συνδέεται με την αύξηση του πληθυσμού των αστέγων. Πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς, μη έχοντας πρόσβαση σε βασικές ανάγκες όπως στέγαση, τροφή, ασφάλεια κτλ, ξεκινούν τη χρήση ουσιών. Αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Αθήνας καλείται να το αντιμετωπίσει το προσωπικό του Στέκι 46 καθημερινά, να διευκολύνει και να περιθάλψει με όσο μέσα έχει αυτά τα άτομα.

Μια ακόμα ιδιαιτερότητα του πληθυσμού που προέκυψε μέσα από τις συνεντεύξεις είναι η ραγδαία εξάπλωση της χρήσης ΣΙΣΑ στην Αθήνα. *‘Η κατάσταση έχει ξεφύγει αρκετά με το ΣΙΣΑ. πολύ μεγάλη δυσκολία και επικοινωνία και... είναι σε μια κατάσταση στην οποία το ΣΙΣΑ εντείνει το ψυχιατρικό περισσότερο και είναι σε μια κατάσταση που δεν μπορούνε να επικοινωνήσουνε, έχουν παραληρηματικές ιδέες έχουνε διεγερτικά συμπλέγματα έχουνε... ε... λίγο δηλαδή να υπάρχει ένα υπόβαθρο από*

πίσω, με το ΣΙΣΑ επειδή είναι και διεγερτικό, κάνει αδύνατο, κάνει πάρα πολύ δύσκολη τη διαχείριση'. (Μαρία,35) Σε αυτό το απόσπασμα αναδεικνύεται ένα χαρακτηριστικό των ληπτών υπηρεσιών που έχει να κάνει με την ουσία την οποία καταναλώνουν. Το ΣΙΣΑ, η διαφορετικά η κρυσταλική μεθαμφεταμίνη, έχει επιρροή στη συμπεριφορά και τη διάθεση των χρηστών που καθιστούν την επικοινωνία και την διαχείριση τους ιδιαίτερα δύσκολη. Το προσωπικό του χώρου εποπτευόμενης χρήσης, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει πολλές φορές επιθετικές συμπεριφορές, που δυσκολεύουν το έργο και αυξάνουν τα επίπεδα του στρες.

Κεφάλαιο 2

Περιορισμοί της λειτουργίας του Στέκι 46 σε σχέση με τη παροχή υπηρεσιών

Αναφερθήκαμε ως τώρα, στις υπηρεσίες που παρέχει το Στέκι 46 στο πληθυσμό των ενεργών χρηστών ουσιών στην Αθήνα, όπως αυτές προέκυψαν από τις συνεντεύξεις με τους εργαζόμενους της δομής. Ωστόσο, μέσα από αυτή τη διαδικασία προέκυψαν και κάποιοι περιορισμοί στην διαδικασία εξυπηρέτησης των ωφελούμενων, τους οποίους θα προσπαθήσω να αναδείξω σε αυτό το κεφάλαιο κατηγοριοποιώντας τους σε κοινωνικό-οικονομικούς, ζητήματα οργάνωσης και κόπωση του προσωπικού.

A. Οικονομικοί και Κοινωνικοί Περιορισμοί

Τα εμπόδια που μπορούν να προκύψουν σε ένα χώρο εποπτευόμενης χρήσης μπορεί να εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Ένα από αυτούς είναι η επιρροή της υπάρχουσας κοινωνικό-οικονομικής κατάστασης της χώρας. Έχοντας περάσει μέσα από μια περίοδο οικονομικής κρίσης και μετά την πανδημία του κορονοϊού, έχουμε παρατηρήσει τη συρρίκνωση των οικονομικών πόρων που δίνονται για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού, είναι η έλλειψη έρευνας στο γενικό πληθυσμό όπως αναφέρετε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά *‘Στην Ελλάδα, κυρίως ελλείπει χρηματοδότησης, στη διάρκεια της 15ετίας 2004-2019 δεν έχει υλοποιηθεί έρευνα για τη χρήση ουσιών στον γενικό πληθυσμό’* Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθυσμού των ληπτών ουσιών, φέρνει τις δομές και τους εργαζόμενους στο κλάδο σε δύσκολη θέση ως προς την ικανοποίηση των αναγκών των ωφελούμενων. *‘Όλες οι πολιτικές επηρεάζουν και κυρίως ε... τα οικονομικά δεδομένα. Δηλαδή δεν έχουμε αναλώσιμα πολλές φορές εδώ πέρα. Δηλαδή... οι πόροι οι οικονομικοί που δίνονται για την απεξάρτηση και τη μείωση της βλάβης είναι ελλιπής. Οπότε δεν είχαμε... τις προηγούμενες δύο βδομάδες δεν είχαμε χαρτί να τους δώσουμε ή δεν είχαμε συσκευασίες για να τουςβάλουμε τα τρόφιμα τους. Όποτε... κοινωνικό-πολιτικό είναι αυτό τώρα, όταν δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι....’* (Νίκος,32) Το προσωπικό, όπως και σε πολλές άλλες δομές έτσι και στο χώρο εποπτευόμενης χρήσης, αντιμετωπίζει συχνά ελλείψεις σε βασικά είδη, κάτι το οποίο προφανώς έχει

να κάνει και με την αύξηση του πληθυσμού των ενεργών χρηστών και κατά επέκταση και της προσέλευσης τους στη δομή, που δεν πάει δυστυχώς σε συνάρτηση με τα ποσά που λαμβάνει ο χώρος.

Η μείωση των οικονομικών πόρων φαίνεται και στην έλλειψη δομών στο δίκτυο που κατασκευάζεται για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών. *‘Τόσο με τη κρίση όσο και με τον κορονοϊό υπήρχε και συρρίκνωση των πόρων όσων αφορά, χρηματικών και μη, όσων αφορά την υποστήριξη των ωφελούμενων. Καταλαβαίνεις ότι οι ανάγκες αυξάνονται και οι πόροι... ναι μεν είναι πεπερασμένοι αλλά και με την οικονομική κρίση και με τον κορο... και με την περίοδο του κορονοϊού πολλές υπηρεσίες μειώθηκαν ή και έκλεισαν, υπηρεσίες όταν λέω εκτός οργανισμού. Που μας υποστήριζαν στο παρελθόν... περιόρισαν τους πόρους τους ή και κάποιες έκλεισαν τελείως.[...] αποτυπώνεται, ότι εφόσον με κάποιες υπηρεσίες που συνεργαζόμασταν στο παρελθόν, σήμερα, είτε μείωσαν τις υπηρεσίες τους είτε έκλεισαν, δυσκολία όσον αφορά την παραπομπή διασύνδεση των ωφελούμενων. (Γιώργος, 42)* Έτσι παρόλο που μπορεί ένα άτομο να απευθυνθεί στο ΧΕΧ για την ικανοποίηση κάποιου αιτήματος του, μπορεί οι εργαζόμενοι να μην έχουν τη δυνατότητα να το εξυπηρετήσουν γιατί δεν υπάρχουν άλλες δομές διαθέσιμες για να προωθήσουν το αίτημα του, ή να υπάρχει μεγάλο χρονικό διάστημα αναμονής. (πχ. Περιορισμός θέσεις στους ξενώνες)

Η έλλειψη χρηματοδότησης παρουσιάζεται στα λόγια των συνεντευξιζόμενων και με τη μορφή έλλειψης προσωπικού. Προκύπτει σε αρκετές συνεντεύξεις ότι χρειάζονται περισσότερο κόσμος να δουλέψει στη δομή σε διάφορα πόστα. Αρχικά, διατυπώνεται η ανάγκη για περισσότερο ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό. *‘να έχουμε περισσότερο προσωπικό ενδεχομένως, γιατρούς περισσότερους που θα χρειάζοντουσαν ανάλογα τη περίπτωση και βέβαια ψυχιατρικές εκτιμήσεις ή ακόμα και φύλακες.’ (Στέφανος, 47)*, καθώς οι τραυματισμοί και οι υγειονομικές ανάγκες των ναρκομανών είναι πολυάριθμες, το ιατρικό προσωπικό είναι συνεχώς απασχολημένο. Αντίστοιχα, οι ψυχιατρικές ανάγκες των μελών φαίνεται να μην καλύπτονται καθώς δεν υπάρχει συνεχής παρουσία ψυχιάτρου στο χώρο. Στο τελευταίο αυτό ζήτημα, έγιναν αρκετές αναφορές, στην ανάγκη δηλαδή να υπάρχει μόνιμα ψυχιατρική φροντίδα και εκτίμηση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα ζητήματα της ασφάλειας. ‘Όπως αναφέρει και ο ίδιος ο φύλακας του κτηρίου ‘είμαι για όλο το κτήριο οπότε ας πούμε έχω τη γενική ασφάλεια του κτηρίου, που έχει να κάνει με τις πόρτες, που έχει να κάνει με όλο το κτήριο. άσχετα που δεν μπορώ να το κάνω αυτή τη στιγμή. αυτή είναι... κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα γίνει.’(Κώστας,45) Ο παραπάνω συνεντευξιαζόμενος αναφέρει ότι παρόλο που θα έπρεπε να εποπτεύει όλο το κτήριο δεν έχει αυτή τη δυνατότητα καθώς οι δύο εισοδοί θα έπρεπε να μείνουν αφύλακτες ‘...κανονικά θα έπρεπε να έχουμε τρεις φύλακες το πρωί τώρα έχουμε δύο, ή τα απογεύματα που είχαμε δύο έχουμε έναν. Έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική του οργανισμού[...]. Έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική του οργανισμού, δεν θέλει να διαθέσει λεφτά για την ασφάλεια μας οπότε κόβει... κόβει από την .. κόβει από διάφορα κομμάτια. Τα οποία είναι πολύ σημαντικά βέβαια για τη λειτουργία’ (Νίκος,32) Η πλειονότητα των συνεντευξιαζόμενων έθεσε ζήτημα ασφάλειας, από διαφορετικές οπτικές ο καθένας και η καθεμία. Τα ζητήματα αυτά προκύπτουν και από την έλλειψη προσωπικού αλλά και από τη διαμόρφωση του χώρου. Η ασφάλεια ωστόσο, δεν θα πρέπει να περιορίζεται στις εισόδους του κτηρίου καθώς, μπορούν να προκύψουν περιστατικά και μέσα στο χώρο, κάτι για το οποίο προς το παρόν δεν υπάρχει πρόληψη. Η έλλειψη ασφάλειας στο χώρο δημιουργεί συχνά ανασφάλεια στο προσωπικό, ενώ οδηγεί σε τακτικό διάστημα σε ολιγόλεπτο κλείσιμο της δομής ώστε να λυθεί κάποια ένταση, ή να διαχειριστούν ένα επείγον περιστατικό. ‘ένα πρόσφατο που μπορώ να θυμηθώ... είναι ένα περιστατικό με έναν ωφελούμενο που μπήκε μέσα, χωρίς να έχει το υλικό να κάνει τη χρήση, έκατσε στη καρέκλα δεν έβγαινε έξω... του μιλήσαμε, σχεδόν όλοι του μιλήσαμε, και εγώ και όλοι οι συνάδερφοι που μπορούσαμε... χρειάστηκαν ώρες, να κλείσουμε το χώρο, και τελικά να έρθει η αστυνομία και να τον βγάλει. Σε ψυχολογικό κομμάτι μπορεί να ήταν ήρεμος, αλλά ήταν και αγχωτικό... γιατί είχαμε εντοπίσει ότι είχε πάνω του... διάφορα κατσαβίδια, ξυράφια και τέτοια... οπότε δεν μπορείς να εφησυχάσεις ότι δεν μπορεί ξαφνικά να σηκωθεί και να... άρα ήμουν σε αρκετά εγρήγορση γιατί δεν ξέραμε σε τι... θα μας βγάλει.’ (Κώστας, 45) Επιπλέον, προκύπτει το ερώτημα με ποιους τρόπους μπορούν να διαχειριστούν οι εργαζόμενοι ή ο φύλακας ένα βίαιο περιστατικό, καθώς δεν υπάρχει κάποια εκπαίδευση ή εξοπλισμός για τέτοιες περιστάσεις.

Μια άλλη μεγάλη δυσκολία που προκύπτει από το κοινωνικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει η δομή, είναι η συνεργασία και η ανάγκη για δικτυώσεις με άλλες κρατικές δομές. Σε πολλές περιπτώσεις, ίσως και σε καθημερινή βάση, θα χρειαστεί το προσωπικό να επικοινωνήσει και να καλέσει είτε την αστυνομία είτε το ΕΚΑΒ για κάποια κατάσταση που νοιώθουν ότι ξεφεύγει από το έλεγχο τους. Η απουσία ή η καθυστέρηση της παρέμβαση από τους παραπάνω φορείς οδηγεί το προσωπικό του χώρου εποπτευόμενης χρήσης να αντιμετωπίσει πολλά περιστατικά, που συχνά δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του. *‘Είναι αρκετά δύσκολο το σύστημα υγείας στην Ελλάδα ούτως ή άλλως. Και δεν τους δέχεται και εύκολα αυτούς τους ανθρώπους, λόγω της χρήσης και όλα αυτά. [...] Το θέμα όμως είναι ότι εδώ είναι απλά αντιμετώπιση... και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι.. έχουν έρθει, είμαστε .. λειτουργούμε ουσιαστικά σαν ΤΕΠ. Μέχρι και μαχαιρωμένοι έχουν έρθει εδώ. Και έρχονται εδώ. Γιατί είναι πιο εύκολη η πρόσβαση σε αυτούς εδώ. Εγώ δεν είμαι ΤΕΠ όμως, είμαι ΧΕΧ.’* (Μαρία,35) Το προσωπικό καλείται να διαχειριστεί αυτή τη κατάσταση, καθώς παρεμβαίνει στη πρώτη γραμμή και δεν υπάρχει προς το παρόν, σύστημα δομών ώστε να απορροφήσει το φόρτο εργασία που προκύπτει. Δηλαδή, ο κοινωνικός στιγματισμός που μπλοκάρει τους ενεργούς χρήστες από τα δημόσια νοσοκομεία, μεταφέρει αναπόφευκτα το βάρος της περίθαλψης τους σε μονάδες όπως το ΧΕΧ. *‘Όταν μας είχε έρθει ο ένας ήταν μαχαιρωμένος, βέβαια δεν μπορώ να πω το ΕΚΑΒ ήρθε σε 10 λεπτά. Πάλι καλά. είχαμε την ... είχαμε και τους δύο γιατρούς εδώ. Ήτανε πάνω στην αλλαγή της βάρδιας, οπότε είχαμε και τους δύο γιατρούς και μπορέσαμε και το αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ καλά το περιστατικό. ήρθε αμέσως και το ΕΚΑΒ τον πήρε αμέσως. Αλλά σε γενικές γραμμές το ΕΚΑΒ δεν έρχεται’* (Μαρία,35) Παρουσιάζεται λοιπόν, ένα ζήτημα το οποίο δυσκολεύει αρκετά την λειτουργία του ΧΕΧ, καθώς ένας από τους βασικούς του στόχους είναι η διασύνδεση. Όταν λοιπόν, το δημόσιο σύστημα υγείας δεν αναλαμβάνει το ρόλο του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, το δίκτυο των δομών δεν μπορεί να λειτουργήσει και οι ωφελούμενοι συγκεντρώνουν τα αιτήματα τους σε όποια υπηρεσία έχουν πρόσβαση, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο χώρος εποπτευόμενης χρήσης. *‘Στο εξωτερικό και το ΕΚΑΒ έρχεται μέσα σε 4-5 λεπτά και η αστυνομία είναι απ’ έξω οπότε υπάρχει ασφάλεια και για την υγεία των ωφελούμενων και για την ασφάλεια του προσωπικού’* (Νίκος, 32). Κάποιοι συνεντευξιαζόμενοι, κάνουντας σύγκρισή με τις αντίστοιχες

δομές του εξωτερικού, προσπαθούν να αναδείξουν αυτά τα ζητήματα που επεξεργαζόμαστε σε αυτό το κεφάλαιο. Παρόλο που η δομή, βάση κανονισμών αποφεύγει να καλεί την αστυνομία δεν είναι λίγες τα περιστατικά που αναγκάστηκαν, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω σε αυτό το κεφάλαιο. Ωστόσο, είναι εμφανής η έλλειψη ασφάλειας και για το προσωπικό και για τους λήπτες υπηρεσιών. Σε μια άλλη συνέντευξη, η συμμετέχουσα στην έρευνα αναφερόμενη σε ένα δύσκολο και βίαιο περιστατικό που αντιμετώπισαν μέσα στο χώρο εποπτευόμενης χρήσης, λέει *‘Και σε αυτήν την απόπειρα ανθρωποκτονίας στην οποία ουσιαστικά ήμασταν, ούτε αστυνομία μπορέσαμε να καλέσουμε γιατί είχαμε μια εντολή να μην καλέσουμε αστυνομία [...] Για καλύτερη προστασία μας, μην καλέσετε την αστυνομία διαχειριστείτε το περιστατικό, υπενθυμίστε να μην κάνει χρήση έξω στο δρόμο, αυτός που μαχαίρωνε...’* (Ελένη, 27)

Από τις παραπάνω παραγράφους προκύπτει ότι η δομή σε επίπεδο δικτύωσης είναι σε ένα βαθμό απομονωμένη, αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έννοια. Ενώ, η επιτυχία της στοχοθεσίας της προκύπτει από την συνεργασία με άλλες δομές, στη πράξη φαίνεται να χρειάζονται βελτίωση οι σχέσεις επικοινωνίας και η συνεργασία πάνω στις υπηρεσίες που αλληλοκαλύπτουν. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να μείνουμε στο ότι ο χώρος εποπτευόμενης χρήσης δεν μπορεί και δεν θα έπρεπε να καλύπτει τις υπηρεσίες του δημόσιου συστήματος υγείας. Όμως καθώς η φύση του χώρου εποπτευόμενης χρήσης είναι τέτοια, το προσωπικό αναγκάζεται να ανταποκριθεί σε καταστάσεις επείγοντος (σοβαροί τραυματισμοί, εμφράγματα κτλ), στα οποία για να υπάρξει αποτελεσματικότητα οφείλει το ΕΚΑΒ και τα νοσοκομεία να μπορούν να ανταπεξέλθουν άμεσα. Επιπλέον, η πολιτική της δομής να μην καλεί την αστυνομία έχει φέρει το προσωπικό πολλές φορές σε δύσκολη θέση όπως αποκαλύπτεται και από τις συνεντεύξεις. *‘εδώ υπάρχει πολιτική να μην καλούμε την αστυνομία το οποίο έχει μια λογική αλλά όταν συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό, το οποίο απειλεί τη ζωή είτε του προσωπικού είτε κάποιου ανθρώπου δεν έχει νόημα να μην την καλούμε’* (Νίκος, 32) Παρόλο που αναφέρθηκε σε αρκετά σημεία αυτός ο κανονισμός δεν αναλύθηκε περαιτέρω. Έτσι μπορούμε μόνο να υποθέσουμε, ότι αυτό γίνεται για τη προστασία των εξαρτημένων, οι οποίοι αρκετά συχνά είναι εμπλεκόμενοι με παράνομες δραστηριότητες, καθώς και για την διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της

δομής και για την εξασφάλιση μιας ομαλότητας σε επίπεδο γειτονίας. Η ενίσχυση επομένως όλων των δομών του δικτύου που συμβάλει στην αντιμετώπιση των ναρκωτικών και στην φροντίδα των ατόμων που κάνει χρήση είναι απαραίτητη για να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα σε συνολικά και σε επίπεδο δομής μεμονωμένα.. *‘Καμία δομή δεν μπορεί να σταθεί από μόνη της. Γιατί οι πόροι είναι πεπερασμένοι, εντάξει? εεε... χρειάζονται συνεργασίες. Σταθερές που να εξελίσσονται. Εγώ... είμαι υπέρ των συνεργασιών και εντός και εκτός οργανισμού. Stay holders. Είναι το πρώτο για εμένα που χρειάζεται’* (Γιώργος, 42)

Η στάση της γειτονίας είναι ένας ακόμα περιορισμός τον οποίο καλούνται να διαχειριστούν οι εργαζόμενοι στο Στέκι⁴⁶. *‘...κοινωνικά πάντα υπάρχει θέμα και στα ΧΕΧ του εξωτερικού. Όλα τα ΧΕΧ έχουν πρόβλημα με τη γειτονιά... με το χώρο πίσω... το γύρο γύρο, μαγαζιά ένοικους, πολίτες τέλος πάντων, καταστηματάρχες και όλα αυτά.’* (Μαρία,35). Την αντίδραση της γειτονίας, τη συναντάμε σαν περιορισμό και στην βιβλιογραφία που υπάρχει για τις αντίστοιχες δομές του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, αναφέρεται και στο βιβλίο του Κ. Γαζγαλίδης *‘Ναρκωτικά: εγχειρίδιο για τη μείωση της βλάβης’* ως ένα από τα κυρίως προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώροι εποπτευόμενης χρήσης. *Πάνω σε αυτό το ζήτημα, σε άλλη συνέντευξη αναφέρεται: ‘Δεν θέλει τις φασαρίες που γίνονται. Τόσο για το χώρο πάει στο διάολο αλλά το... τις φασαρίες που γίνονται και να μην κάθονται στο δρόμο να κάνουν χρήση εδώ. Εντάξει έχει ένα νόημα, ανοίξαμε για να κάνουν εντός.’* (Ελένη, 27) Γίνεται εμφανές επομένως, ότι η λειτουργία του χώρου προσελκύει στη γειτονία δραστηριότητες οι οποίες δεν μπορούν να ελέγχουν ή πλαισιωθούν από το προσωπικό με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εντάσεις με τους γείτονες κτλ. Σ’ αυτή τη στάση των ατόμων που ζουν και εργάζονται γύρο από τη δομή, έχει συμβάλει ο στιγματισμός της χρήσης και των εξαρτημένων. Επομένως, αντί η δομή να βοηθάει σε ένα βαθμό στο να πλαισιωθεί αυτός ο πληθυσμός και να δημιουργήσει γέφυρες ανάμεσα στο κόσμο των ναρκωτικών και στην υπόλοιπη κοινωνία, καταλήγει να λειτουργεί ως πόλος έλξης των εξαρτημένων ατόμων στους δρόμους γύρο από τη δομή, τη διακίνηση ουσιών, τις βίαιες συμπλοκές που μπορεί να προκύψουν καθώς και άλλες κοινωνικές συνέπειες της χρήσης, οι οποίες λειτουργούν αρνητικά στην υπέρβαση του κοινωνικού στιγματισμού. Ενώ, παράλληλα αυτή η πραγματικότητα, δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τη λειτουργία της δομής αφού το προσωπικό οφείλει να ασχολείται και

με το τι συμβαίνει έξω από την δομή και να διαχειρίζεται τα παράπονα ή ακόμα και την αστυνομία όποτε αυτή καλείται. *‘Στο εξωτερικό είναι διαφορετικά τα πράγματα στην Ελλάδα δεν νιώθω ότι... έγινε με τις προδιαγραφές που θα έπρεπε να γίνει. Επίσης, δεν χωράει.... δηλαδή στις άλλες δομές στο εξωτερικό από ότι έχω μάθει, χωρίς να έχω πάει, ασχολούνται μόνο με αυτό. Και ίσως να έχει και ένα νόημα να ασχολείται μόνο με ενεργή χρήση που γίνεται μπροστά στα μάτια σου και να ασχολείται μόνο με αυτό. Όταν έχεις να ασχοληθείς με το να τον διασυνδέσεις, να δώσεις τηλέφωνα, να κάνεις το ένα, να δώσεις αποφυλακιστήρια.. όλα αυτά ίσως είναι too much. Συν συγκρούσεις, συν ότι η αστυνομία δεν έρχεται, συν ότι η φιλοσοφία είναι να μην καλούμε και αστυνομία..’* (Ελένη,27). Όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν αναφερθεί, λειτουργούν συσσωρευτικά για το προσωπικό αυξάνοντας το φόρτο εργασίας τους και περιπλέκοντας τις καταστάσεις που καλούνται να διαχειριστούν σε κάθε περίπτωση.

B. Οργάνωση Δομής - Πιάτσα πολυτελείας

Στην προσπάθεια μας, να εξετάσουμε τους περιορισμούς που προκύπτουν στη λειτουργία του Στέκι46, πέρα από τους εξωτερικούς παράγοντες που αναλύθηκαν παραπάνω προέκυψαν από τις συνεντεύξεις και ορισμένοι εσωτερικοί παράγοντες. Η κριτική αυτή, επικεντρώθηκε σε ζητήματα οργάνωσης και εκπαίδευσης.

Πιο αναλυτικά, μέσα από τις συνεντεύξεις αναδείχτηκε η ανάγκη για ομαδικότητα και καλύτερη οργάνωση της δομής. *‘Χρειάζεται να υπάρχει συχνή επικοινωνία του προσωπικού μεταξύ του στα πλαίσια των ομάδων, ε... στις ομάδες αυτές να συμμετέχει και η προϊσταμένη για να έχει.. απευθείας γνώση όλων όσων συμβαίνουν. Και όλα όσα μας απασχολούν, χρειάζεται να συγκεντρώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα , γιατί εμείς ως υφιστάμενοι δεν δίνονται λύσεις από μόνοι μας. κάνουμε κάποιες διαπιστώσεις, αυτές οι διαπιστώσεις ιεραρχικά χρειάζεται να πηγαίνουν στην διοίκησή, μέσω της προϊσταμένης μας.’* (Γιώργος,42) Το αίτημα για ομαδικό πνεύμα προέκυψε στη πλειονότητα των συνεντεύξεων, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ομαδικές συνεδρίες και καλύτερη επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού. Ενώ παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη για κεντρική γραμμή παρέμβασης και αίσθημα ομαδικότητας και εποπτείας της δουλειάς των εργαζομένων. *‘είναι πολύ πιθανό να γίνει κάτι τέτοιο αν δεν φροντιζόμαστε και δεν είμαστε όλοι από μια κοινή γραμμή. Το κοινή γραμμή δεν*

υπάρχει εδώ. Δυστυχώς δεν υπάρχει.. Μπορεί να συμφωνούνται πράγματα σε ομάδες που γίνονται... σπάνια πλέον. Αλλά όλο αυτό αναιρείται κάτω στη πράξη. Και αναιρείται μπροστά στα μέλη. Δηλαδή μπορεί εγώ να βάλω ένα όριο γιατί... και γιατί έτσι είναι και γιατί έτσι μου έχουν πει να το κάνω έτσι; Δεν ζύπνησα μια μέρα και μου ήρθε, τώρα κάτω... κάπως έχει ειπωθεί όλο αυτό. Και την ίδια στιγμή μπροστά στον άλλον, ένας άλλος συνάδερφος να το πει, εγώ θα στο δώσω γιατί αυτός είναι ο κανόνας. Και το γκρεμίζει όλο αυτό' (Δήμητρα, 29) Η έλλειψη επομένως καλής επικοινωνίας, ορίων και συνεργασίας ανάμεσα στο προσωπικό είναι κάτι το οποίο εμποδίζει την ορθή λειτουργία της δομής και εκθέτει εργαζόμενους μπροστά σε μέλη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η παραπάνω παρατήρηση, είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς όπως έχει αναφερθεί και σε άλλο σημείο της εργασίας, ένας από τους βασικούς στόχους των χώρων εποπτευόμενης χρήσης είναι να προσφέρουν ένα οργανωμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορέσουν οι χρήστες να ενταχθούν σταδιακά και να δημιουργήσουν σχέσεις επικοινωνίας. Όταν όμως, το πλαίσιο δεν είναι αρκετά οργανωμένο η δυνατότητα αυτή είναι εξίσου περιορισμένη. 'αν υπήρχε σωστή συνεννόηση παύλα επικοινωνία με.. του προσωπικού, πιο οργάνωση, νομίζω ότι θα βοηθούσε και στο.. έξω. Αυτό που έχεις μέσα, αναγκαστικά το εμφανίζεις και έξω. Αν έχεις αναρχία, σε εισαγωγικά αναρχία, μέσα, θα το βγάλεις και έξω. Αν.... έχω εντοπίσει ότι υπάρχουνε θέματα επικοινωνίας, θέματα... και επειδή εγώ έχω να κάνω με όλες τις ειδικότητες και με όλους τους ορόφους, ε... καταλαβαίνεις ότι ακούω... άλλο ο ένας, άλλο ο άλλος, όχι θα κάνουμε αυτό όχι θα κάνουμε το άλλο.... Είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει σχεδόν παντού βέβαια, υπάρχει παντού στο OKANA, και σε μονάδες ακόμα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και όταν είσαι φύλακας το εισπράττεις πιο εύκολα γιατί... είσαι η πρώτη γραμμή. Οπότε σου λένε όλοι, θα κάνεις αυτό, όχι θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις το ένα.... Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί τη στιγμή που έχεις να κάνεις με ωφελούμενους, περιμένεις κάποια πράγματα αλλά... δεν περιμένεις αυτά που γίνονται μέσα και δεν θα έπρεπε να γίνονται' (Κώστας, 45) Η έλλειψη ομαδικού πνεύματος και συλλογικού οράματος λειτουργεί ως περιορισμός, όπως αναγνωρίζουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Επιβαρύνει σε ατομικό επίπεδο τη ψυχολογία το κάθε επαγγελματία, ενώ δημιουργεί εντάσεις και ασυνεννοησία ως προς τη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων.

Ένα από τα πιο συχνά μοτίβα που παρατηρήθηκε στις συνεντεύξεις και επομένως προέκυψε ως θεματική είναι ο όρος πιάτσα πολυτελείας. Φαίνεται πως το προσωπικό αλλά και οι ωφελούμενοι χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο για να περιγράψουν το χώρο εποπτευόμενης χρήσης. *‘...αυτό της πιάτσας γενικά έρχεται πολύ μέσα, εδώ. Είναι πιάτσα πολυτελείας, έτσι το λένε... και το λέμε και οι συνάδερφοι μεταξύ μας. Αλλά έχει να κάνει και με εμάς πολύ αυτό. Δηλαδή με τον καθένα ξεχωριστά και στο σύνολο. Δεν μπορώ εγώ να απαιτώ από έναν άνθρωπο να μην το βλέπει σαν πιάτσα αν και εγώ η ίδια σαν επαγγελματίας δεν του βάζω το όριο και δεν του συμπεριφέρομαι ότι.. ξέρεις εδώ είναι χώρος δεν είναι πιάτσα.’* (Δήμητρα, 29) Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται από τους ενεργούς χρήστες και στην συνέχεια τον οικειοποιήθηκαν και οι εργαζόμενοι της δομής. Αποτυπώνει, όπως προσπαθεί και η συνεντευξιαζόμενη παραπάνω να εξηγήσει, τη συνέχιση του πλαισίου ‘δρόμου’, της πιάτσα και μέσα στη δομή. *‘Γιατί είναι άνθρωποι που σου φέρνουνε το χάος από τη πιάτσα οπότε... αν δεν υπάρχουνε κανόνες αυστηροί να τηρούνται από όλους και από όλο το προσωπικό ...ε... δημιουργείται τεράστια θέμα, γίνεται δηλαδή μια πιάτσα πολυτελείας εδώ’* (Νίκος, 32)

Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες εκφράζουν με τη χρήση αυτής της έννοιας μια ανησυχία για τη οριοθέτηση των ωφελούμενων μέσα στα πλαίσια χρήσης των υπηρεσιών της δομής. Οι συνθήκες υπό τις οποίες καλούνται να ζήσουν οι ενεργοί χρήστες στο δρόμο χαρακτηρίζονται από ανορίωτες συμπεριφορές, έλλειψη συναισθησίας, αδυναμία επικοινωνίας, βιαιότητα κ.α. *‘...κυρίως από τους εξυπηρετούμενους γιατί.... Από τις πιάτσες, από την όλη νοοτροπία τους φέρνουν ένα χάος . Όταν βλέπουνε και εδώ ότι δεν υπάρχει ένα πλαίσιο... με κανόνες, γιατί οι κανόνες είναι Δεν τηρούνται 100% από όλους και από τους... και από τη διοίκηση. Όταν βλέπουν ένα τέτοιο μεγάλο έλλειμμα κάνουν και αυτοί ότι θέλουνε’* (Νίκος,32) Όταν κάνουν χρήση μιας δομής, όπως ο χώρος εποπτευόμενης χρήσης είναι δύσκολο να μουν τα όρια και να πλαισιωθούν οι υπηρεσίες, εφόσον δεν πρόκειται για θεραπευτικά προγράμματα τα οποία έχουν πιο αυστηρούς κανόνες. *‘... Έτσι εμείς συνεχίζουμε την πιάτσα που φέρνουν οι άνθρωποι. Αν προσπαθούμε να το προσεγγίσουμε με τέτοιους τρόπους και μεθόδους και τακτικές, πρέπει να μπαίνει το όριο. Ναι, το γεγονός ότι θέλω να κάνουμε μια συνάντηση, δεν σημαίνει ότι θα έρθω να σε πιάσω, να σου μιλήσω με αυτό τον τρόπο, να σε προσεγγίσω γενικά έτσι για να τη κάνουμε.’* (Δήμητρα, 29) Στο τελευταίο σχόλιο, η συνεντευξιαζόμενη προσπαθεί να

προτείνει τρόπους για να ξεπεραστεί αυτή η λογική και να οριοθετηθεί η σχέση του προσωπικού με τους ωφελούμενους, έξω από τη κουλτούρα και τη φρασεολογία του δρόμου. *‘χωρίς να αποκλείσουμε τον άνθρωπο να μπορέσουμε να δώσουμε τουλάχιστον το minimum των υπηρεσιών που μπορούμε, ώστε να καταλάβει και ο ίδιος ότι έχουν αντίκτυπο αυτά τα οποία κάνει. και ότι δεν μπορεί να εισέρχεται σε ένα χώρο... πρέπει να καταλάβει τη διαφορά της πιάτσας από την υπηρεσία’ (Μαρία,35)*

Ένα ζήτημα που επίσης αναφέρθηκε ως παράγοντας που δυσκολεύει την οριοθέτηση του χώρου και τον διαχωρισμό της από το δρόμο, είναι η διαμόρφωση του χώρου. *‘Ο χώρος έτσι όπως είναι διαμορφωμένος κάτω σίγουρα... είναι προβληματικός ε... και το πως μπαίνουν τα μέλη και με το... ποια δηλαδή είναι η σειρά, το που τοποθετούνται κατά τη γνώμη μου και με αυτά που.. συζητάμε και με τους θεραπευτές κάτω και με τους συναδέλφους, είναι κάπως λάθος, δομημένο εξ αρχής δηλαδή το πράγμα. Και για λόγους ασφαλείας και γενικότερα’ (Δήμητρα,29)* Το κτήριο στο οποίο βρίσκεται ο χώρος εποπτευόμενης χρήσης, δεν φαίνεται να έχει τις προδιαγραφές για να μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια του προσωπικού αλλά και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που να ξεφεύγει με κάποιο τρόπο από την κουλτούρα του δρόμου. Στη παρούσα φάση, από το πεζοδρόμιο με ένα βήμα απλά βρίσκεται κανείς μέσα στο χώρο, στο οποίο γίνεται χρήση, κάνοντας αδύνατο να προληφθεί κάποιο έκτακτο βίαιο σκηνικό, αλλά και αφήνοντας τους χρήστες εκτεθειμένους στο βλέμμα των περαστικών.

Μέσα από τις συνεντεύξεις προκύπτει ένα ακόμα ζήτημα, το οποία συμβάλει στη έλλειψη οργάνωση, την αδυναμία οριοθέτησης του πλαισίου της δομής και την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού. Πρόκειται για την έλλειψη εκπαίδευσης και ομαδικών συναντήσεων, οι οποίες αναφέρθηκαν σε αρκετές συνεντεύξεις. *‘Εκπαίδευση δεν υπάρχει. εκπαίδευση δεν υπάρχει, εγώ στα 20 μου χρόνια δεν έχω πάρει καμία εκπαίδευση. η μόνη εκπαίδευση που πήρα ήταν όταν μας προσλάβανε.. μια βδομάδα, που μας λέγανε γενικά για τον OKANA τι είναι κτλ κτλ. ε... και εγώ στα βαθιά μπήκα. Δηλαδή ήρθα, έκατσα 3 μέρες είδα, και μετά έκατσα στην πόρτα. έτσι; Ακόμα μαθαίνω. ε, θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει εκπαίδευση, αν θες την άποψη μου ναι’ (Κώστας, 45)* Παρόλο που όλο το προσωπικό είναι ειδικευμένο, όλες οι ειδικότητες αναφέρουν ότι θα έπρεπε να υπάρχει εκπαίδευση και εποπτεία

πάνω στη δουλειά τους και στο πως θα έπρεπε να λειτουργούν ατομικά και ομαδικά. *‘σίγουρα οι εκπαιδεύσεις που πρέπει να γίνονται παράλληλα. Δεν υπάρχει αυτό. Έχουν γίνει κάποιες ναι, αλλά σκέψου ότι όταν ήρθα εγώ εδώ, ήμασταν μια μαζική πρόσληψη. Η οποία τελειώνει σε ένα μήνα, δεν μας έχει γίνει καμία εκπαίδευση ακόμα, επίσημη. Δηλαδή, σκέψου ότι.. υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα ναι, να μην ανανεωθούμε ok... έτσι είναι οι συμβάσεις, αλλά είμαστε άνθρωποι που ήρθαμε περάσαμε και δεν εκπαιδευτήκαμε για να είμαστε.’ (Δήμητρα,29)* Η έλλειψη εκπαίδευση δημιουργεί ένα ζωτικό ζήτημα, καθώς συμβάλει στην έλλειψη κοινής γραμμής μεταξύ του προσωπικού, δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας σε ατομικό επίπεδο και δεν βοηθάει τους εργαζόμενους να προσφέρουν της υπηρεσίες τους με τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Στην βελτιστοποίηση παροχή υπηρεσιών και στην υποστήριξη του προσωπικού θα συνέβαλε επίσης και η ύπαρξη σταθερών ομάδων και εποπτείας, τα οποία προς το παρόν φαίνεται να μην διεκπεραιώνονται. *‘Εφόσον δεν υπάρχει εποπτεία... ο οργανισμός δεν παρέχει... και κανένας οργανισμός στην Ελλάδα όχι μόνο αυτός. Δεν παρέχει πληρωμένη θεραπεία έστω ένα μέρος, του ποσού. Όπως είπα εποπτεία... καλά εβδομαδιαία.. αστεία πράγματα. Τουλάχιστον μηνιαία αν ήτανε. ε... και εξαντλητικές συνθήκες στο ότι... [...] με ότι έρχεσαι αντιμέτωπος.... είναι θέμα’ (Ελένη,27)* Σε πρώτο στάδιο η ύπαρξη ομάδων μπορεί να βοηθήσει στη καλύτερη επικοινωνία, στην συλλογικοποίηση των ιδεών και προβληματισμών των εργαζόμενων και στη συζήτηση πάνω στα περιστατικά ώστε να υπάρχει ολιστική και μεθοδευμένη αντιμετώπιση. Σ δεύτερο επίπεδο η εποπτεία, μπορεί να ρυθμίσει τη ορθή λειτουργία της δομής και την οργάνωση των διαδικασιών.

Όλοι οι περιορισμοί που αναφέρθηκαν παραπάνω από τη έλλειψη οργάνωσης και επικοινωνίας στο προσωπικό, την έλλειψη προσωπικού και βασικών υλικών, τα ελλείμματα στην διασύνδεση με διάφορες υπηρεσίες, μέχρι τη διαμόρφωση του χώρου δημιουργούν σε επίπεδο δομής μια ασταθή εικόνα, την οποία αποτυπώνουν οι συνεντευξιαζόμενοι. Η κατάσταση αυτή, νομιμοποιεί τη χρήση του όρου ‘πιάτσα πολυτελείας’ μεταξύ του προσωπικού αλλά και των ωφελομένων. Επιπλέον, επιβαρύνει ψυχικά τους εργαζόμενους, δημιουργώντας ένα αίσθημα ανασφάλειας και ατομικής ευθύνης απέναντι στο αντικείμενο εργασίας τους.

Γ. Εργασιακή Κόπωση και Burnout

Η παράθεση των προβληματισμών των εργαζόμενων παραπάνω δημιουργεί μια εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας του Στεκιού 46 και το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούνται οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες να παρέμβουν. Παράλληλα όμως, αποτυπώνεται ένας καμβάς προβληματισμών ως προς το πώς μπορεί ένα άτομο να ανταπεξέλθει σε αυτές τις συνθήκες. Ήδη γνωρίζουμε από τη σχετική βιβλιογραφία ότι η ματαίωση και το εργασιακό burnout είναι αρκετά σύνηθες στο κλάδο των ναρκωτικών. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε τους παράγοντες που οδηγούν σε αυτή τη κατάσταση, συγκεκριμένα στο χώρο εποπτευόμενης χρήσης στην Αθήνα. Στο φαινόμενο burnout κάνει αναφορά και ο Κ. Γαζγαλίδης σημειώνοντας «Τα προβλήματα που συναρτώνται με τη λειτουργία των χώρων αυτών, όπως εξάλλου γίνεται και με πολλές άλλες υπηρεσίες μείωσης βλάβης [...] και με την υψηλή επιβάρυνση του προσωπικού από το εξαιρετικά απαιτητικό και ψυχοφθόρο αντικείμενο δουλειάς που οδηγεί πολύ συχνά σε φαινόμενα κόπωσης (burnout)» (Γαζγαλίδης, 2005).

Οι χώροι εποπτευόμενοι χρήσης είναι ένας επιπλέον επιβαρυνμένος χώρος για το προσωπικό που τους στελεχώνει, καθώς απευθύνεται σε ενεργούς χρήστες και χρήστριες, αρκετοί από τους οποίους δεν είναι ενταγμένοι σε κάποιο πλαίσιο, εκτός από αυτό της πιάτσας και του δρόμου, και επιπλέον σε σημαντικό ποσοστό δεν επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτό. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, συμβάλει στην ματαίωση που μπορεί να βιώνει ένας εργαζόμενος ή μια εργαζόμενη, καθώς πολλές φορές δεν μπορούν να βρουν κίνητρο και να δουν απτά αποτελέσματα της παρέμβασής τους. *‘Εδώ, ουσιαστικά στην μείωση της βλάβης λειτουργείς με απόλυτη αποδοχή στην χρήση των ανθρώπων. Δεν τιμωρείς, δεν αποκλείεις, προσπαθείς να... είναι τελείως διαφορετική η διαχείριση των περιστατικών, έχοντας να κάνεις με ενεργούς χρήστες, άστεγους, ψυχιατρικά θέματα, σωματικά θέματα άσχημα, πολλά... είναι δηλαδή ένα συνονθύλευμα το οποίο είναι λίγο... είναι πολύ πιο δύσκολο, το πεδίο εδώ. Και το ΧΕΧ συγκαταλέγεται στο πιο νευραλγικό σημείο του... σαν.. να έχεις πόστο εδώ. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι πιο δύσκολο από το ΧΕΧ. Σαν δομή δηλαδή [...] εδώ δηλαδή η άμεση πρόσβαση, γιατί και εδώ έχουνε, υπάρχουνε κάποιοι επιθετικοί άνθρωποι που έρχονται ξέρω εγώ, μπορεί να κάνουνε... και οι ουσίες που πίνουνε, επειδή πλέον αυτά αλλάζουμε συνέχεια, κάνουν ακόμα πιο*

δύσκολη δηλαδή... την διαχείριση. Έχει να κάνει με τη... πως να διαχειριστείς τον ενεργό χρήστη, υπό την επήρεια ουσιών. ' (Μαρία,35) Η παραπάνω συνεντευξιαζόμενη αποτυπώνει μέσα από το λόγο της, της δυσκολίες που προκύπτουν στο χώρο εποπτευόμενης χρήσης. Η διαχείριση του πληθυσμού των ενεργών χρηστών, από μόνη της σαν διαδικασία δημιουργεί στρες και κόπωση στο προσωπικό, καθώς βρίσκονται μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για ενδεχόμενες επιθετικές συμπεριφορές, οι οποίες μπορεί να είναι απειλητικές και ως προς τους ίδιους, χρήστες με τραυματισμούς, overdose κτλ. Επιπλέον, η αύξηση χρήση του ΣΙΣΑ στην Αθήνα, που αναφέρθηκε νωρίτερα, δυσχεραίνει επιπλέον την εργασία τους, καθώς πρόκειται για διεγερτικό ναρκωτικό που από μόνο του αυξάνει τις επιθετικές και απρόβλεπτες συμπεριφορές στους χρήστες.

Μέσα από τις συνεντεύξεις γίνεται εμφανές ότι και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται σε ένα βαθμό ότι ο κλάδος των ναρκωτικών έχει γενικευμένη ματαίωση λόγο αντικειμένου. *‘Και είναι ένας χώρος που υπάρχει συνεχώς ματαίωση. Τρομερή ματαίωση, δηλαδή δεν υπάρχει συνέπεια πουθενά. κλείνουν ένα ραντεβού δεν πηγαίνουνε, κλείνουν συναντήσεις με τους συναδέλφους κάτω και δεν έρχονται... τα φάρμακά τους τα ψυχιατρικά δεν τα παίρνουνε... είναι πάρα πολύ ασθενείς που έχουνε μανιοκατάθλιψη, είναι με σχιζοφρένεια είναι με αγχώδης διαταραχές, καταθλιπτικοί και... έχουνε και τη διαταραχή λόγω της χρήσης ουσιών και την... και το ψυχιατρικό μαζί, διπλή διάγνωση, που αυτό αυτόματα τα κάνει πιο... λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Αυτό είναι είναι η καθημερινή.... είναι αρκετά ψυχοφθόρο σαν πόστο κάτω. [...]... καλά το burnout είναι αναπόφευκτο. Είναι αναπόφευκτο δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μην καείς. κάποια στιγμή, σίγουρα θα καείς.* (Μαρία,35) Η έλλειψη εμφανούς αποτελέσματος από το έργο που παράγουν καθημερινά οι εργαζόμενοι οδηγεί στο αίσθημα απογοήτευση και ματαίωσης. Δηλαδή, όπως γίνεται εμφανές από τα αποσπάσματα, καταβάλουν συνεχώς προσπάθεια να επικοινωνήσουν και να χτίσουν σχέσεις με τους ωφελούμενους και βλέπουν συνεχώς τις ίδιες καταστάσεις και συμπεριφορές να αναπαράγονται.

‘Εγώ νιώθω ότι κάτω συνεχώς συναντιέται ένα προσωπικό κουρασμένο ψυχικά και... ωφελούμενοι οι οποίοι είναι επίσης κουρασμένοι ψυχικά. Οπότε δεν... αυτή τη κούραση κανένας δεν είναι εκεί να ανακουφίσει κανέναν... [...] Και μετά η ψυχική κούραση, δηλαδή από ένα σημείο και μετά... καίγεσαι. και το βλέπεις στο ότι δεν θες να τους

εξυπηρετείς. Δηλαδή εκεί που είχες έρθει για να βοηθήσεις, να βοηθήσεις αυτούς τους ανθρώπους, τελικά καταλήγεις να μην θες ούτε αυτό να κάνεις’(Ελένη,27) Σε αυτή τη συνέντευξη η συμμετέχουσα αναφέρετε στην ψυχική κούραση που προκύπτει από την εργασία με ενεργούς χρήστες, τις συνθήκες μέσα στις οποίες διεξάγεται και τελικά το αποτέλεσμα που είναι η έλλειψη διάθεσης να προωθήσουν τα αιτήματα των ωφελομένων. Η ανασφάλεια και η κόπωση που συγκεντρώνουν οι εργαζόμενοι, μπαίνει εμπόδιο στην διεκπεραίωση αποτελεσματικά της δουλειάς που έχουν να κάνουν. Τα αιτήματα των ωφελομένων ανανεώνονται καθημερινά, ωστόσο δεν υπάρχει, σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις, κάποιος μηχανισμός ή κάποια πρόβλεψη για το πώς το προσωπικό θα διαχειριστεί αυτή τη συνεχή διαδικασία ματαίωσης. *‘δυστυχώς θεωρούν ότι είμαστε βιονικοί... δεν είμαστε όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά θα έπρεπε να είχε πολύ περισσότερο κόσμο.*’ (Κώστας,45) Αναδεικνύεται επομένως, το αίτημα των εργαζόμενων να φροντιστούν και να προστατευτούν από τη δομή μέσα στην οποία εργάζονται.

Ωστόσο, φαίνεται ότι παρά τη ματαίωση που έχουν να διαχειριστούν λόγω αντικειμένου εργασία, προστίθεται σε αυτό το αίσθημα και μια επιπλέον ματαίωση που προκύπτει από τις συνθήκες μέσα στις οποίες καλούνται να εργαστούν. Στο απόσπασμα που ακολουθεί, η συνεντευξιαζόμενη αναφέρεται στο τρόπο που αντιμετωπίζεται το προσωπικό από τη διοίκηση *‘αλλά όταν μιλάς έχουν το αίσθημα ότι πάνω από όλα ο άνθρωπος που εξυπηρετούμε. Καταπατώντας τον άνθρωπο που δουλεύει για τους ανθρώπους που εξυπηρετείς και... υπάρχει ένας ανθρωπισμός μιας ματιάς... τον θεωρώ πολύ υποκριτικό. Αν θες να έχεις έναν ανθρωπισμό, μιας και είσαι σε τέτοια επαγγέλματα, που μάλλον κάποια αισθήματα τέτοια θα έχεις... ας είσαι προς όλους, για να μην φροντίζεις και μονομερώς.*’ (Ελένη,27).

Στην ανασφάλεια και το άγχος που καλείται να διαχειριστεί το προσωπικό, συμβάλει και η ελλιπής φύλαξη του χώρου. *‘το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι η ασφάλεια του χώρου.... Αυτό δημιουργεί τον μεγαλύτερο περιορισμό γιατί όταν φοβάσαι να κάνεις τη δουλειά σου γιατί μπορεί να σου επιτεθούν λεκτικά είτε σωματικά περιορίζει τις δυνατότητές σου..*’(Γιώργος,32) Η συνεχής έκθεση σε βίαιες συμπεριφορές καθώς και η συνειδητοποίηση ότι δεν υπάρχει πραγματικά πρόβλεψη για να αποφευχθεί κάποιος τραυματισμός, συμβάλει στο στρες και την κόπωση που βιώνουν οι εργαζόμενοι. Οι

επαναλαμβανόμενες καταστάσεις που έχουν καλεστεί να αντιμετωπίσουν, επιβεβαιώνουν κάθε φορά ότι είναι θέμα τύχης ότι δεν είχαν κάποια σοβαρότερη συνέπεια, πέρα από το κλείσιμο της δομής για κάποιο χρονικό διάστημα.

Μέσα σε αυτή τη συνθήκη το προσωπικό αναπτύσσει μηχανισμούς και τρόπους να διαχειριστεί τη κατάσταση σε ατομικό επίπεδο, για να ‘επιβιώσει’, όπως αναφέρει μια συνεντευξιαζόμενη και ως εργαζόμενη και ως άνθρωπος. *‘κοπιάσαμε και προσπαθήσαμε γι’ αυτό και αναγκαστήκαμε να το αποκτήσουμε δηλαδή στη πορεία. (αναφέρεται στα εργαλεία που έχουν για να διαχειριστούν το αντικείμενο εργασίας τους) Για να.... δες το με πολλά εισαγωγικά, να επιβιώσουμε εδώ μέσα. Και σαν εργαζόμενοι και... γενικότερα. Δεν υπάρχει δυστυχώς φροντίδα, είναι ένας χώρος που... σίγουρα πρέπει να έχει υποχρεωτική εποπτεία. Δεν γίνεται αυτό, πρέπει να γίνονται ομάδες... οι ομάδα να είναι... μην υπάρχει το splitting... είναι πολλά τέτοια θέματα.. που αν δεν λυθούν, δυστυχώς, θα υπάρξει διάσπαση και θα υπάρξει και περιστατικό που... θα έρθει στην ομάδα, (Δήμητρα, 29)* Η έλλειψη ομαδικότητας και εποπτείας που αναφέρθηκε νωρίτερα φαίνεται να συμβάλει στη δυσφορική κατάσταση που καλούνται να αντιμετωπίσει το προσωπικό. Συμπεραίνουμε επομένως ότι κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος που φέρει ο κλάδος της αντιμετώπισης των ναρκωτικών μόνος του και υπάρχει ανάγκη για περισσότερη ομαδικότητα και συντονισμό του προσωπικού. Πέρα από τη ματαίωση, το αίσθημα της ανασφάλειας για τη σωματική ακεραιότητα του προσωπικού προκαλεί επιπλέον άγχος και δυσκολία στο να διεκπεραιώσουν την εργασία τους. Επομένως, λόγο των αδυναμιών που αναφέρθηκαν παραπάνω, κάθε επαγγελματίας βρίσκει μόνος του λύσεις και μεθόδους να διαχειριστεί το στρες και τη ματαίωση *‘Να φροντιστείς γιατί αυτό που καλείσαι συνεχώς να κάνεις είναι.. εκτός από τα φυσιολογικά όρια. Και αυτό το άνευ όρων εδώ πέρα που υπάρχει...ε... δεν έχουμε μια άνευ όρων φροντίδα, οπότε κάποια στιγμή εξαντλείσαι. Άρα αυτό μαθαίνω επαγγελματικά. Μέχρι που δίνω και τι παίρνω. Και πως μετά, θα κάτσω εγώ μετά να με προστατέψω για να αντέξω να βγάλω και τις επόμενες μέρες ή τις υπόλοιπες δουλείες που υπάρχουνε. (Ελένη,27)*

Κεφάλαιο 3

Προτάσεις βελτιστοποίησης των υπηρεσιών από τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες

Κάθε δομή που λειτουργεί πάνω στη διαχείριση και αντιμετώπιση των ναρκωτικών, αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες καθημερινά. Οι χώροι που ασχολούνται με τη μείωση της βλάβης είναι επιπλέον επιβαρυνμένοι καθώς παρεμβαίνουν στη πρώτη γραμμή, δηλαδή οργανώνουν τη πρώτη παρέμβαση που θα γίνει στο πληθυσμό που ζει και κινείται στο δρόμο και στις πιάτσες. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει κινδύνους και έντονο στρες για το προσωπικό που πρέπει να διαχειριστεί καταστάσεις επειγόντων περιστατικών συνεχώς και απρόβλεπτες συμπεριφορές. Το Στέκι46, αποτελεί τη πρώτη προσπάθεια λειτουργίας ενός χώρου εποπτευόμενης χρήσης στην Αθήνα, και παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και σαν δομή αλλά και τα άτομα που το στελεχώνουν παράγει σημαντικό έργο στα πλαίσια της μείωσης της βλάβης. Μέσα από τις συνεντεύξεις προέκυψαν κάποιες σκέψεις και προτάσεις των ατόμων που εργάζονται στο χώρο αυτό, που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών αλλά και στις συνθήκες εργασίας των ίδιων.

Παροχή Υπηρεσιών

Αρχικά, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, το Στέκι46, εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό ατόμων είτε για ασφαλή χρήση είτε για γραφειοκρατικές διαδικασίες, είτε για ιατρονοσηλευτική φροντίδα. Μέσα από τις συνεντεύξεις αναδείχθηκε σαν προβληματισμός κατά πόσο μπορεί το προσωπικό να ανταπεξέλθει στη συνεχή αύξηση του πληθυσμού και στον αυξανόμενο αριθμό αιτημάτων για παροχή υπηρεσιών. Ορισμένοι συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν ως λύση στη μείωση του φόρτου εργασίας τους την πρόσληψη προσωπικού, ωστόσο αναδείχθηκε κυρίως η ανάγκη για να λειτουργήσουν και άλλοι χώροι εποπτευόμενης χρήσης στην Αθήνα. Η σκέψη αυτή μπορεί να συμβάλει στην αποσυμπίεση του χώρου και του προσωπικού, ενώ μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη διαπροσωπική επικοινωνία των ωφελούμενων με τους εργαζόμενους. Επιπλέον, θα ενισχύσει την παρέμβαση που στοχεύει στη μείωση βλάβης και σε χρήστες άλλων περιοχών της πρωτεύουσας. Αυτές οι σκέψεις αποτυπώνονται από μια συνεντευξιαζόμενη στο ακόλουθο

απόσπασμα: *‘Τώρα καλό θα ήταν, για μένα τουλάχιστον, ώστε να... επειδή είναι το μοναδικό XEX που υπάρχει στην Αθήνα καλό θα ήταν... δεν χρειάζεται ούτε να ανοίξουν παραπάνω βάρδιες για το προσωπικό... πρέπει να ανοίξει και άλλο XEX. Για μένα, δηλαδή καθαρά προσωπική άποψη. Γιατί μοιραία, κάποια στιγμή από τις πολύ έντονες προσελεύσεις, δηλαδή... η ίδια η δομή θα καταρρεύσει κάτω από το ίδιο της το βάρος. Όποτε θεωρώ ότι καλό θα ήταν να ανοίξει και άλλο XEX. Αυτό θεωρώ εγώ. Προσωπικά. Ότι θα ήταν καλύτερο δηλαδή, και για αποσυμπίεση του κόσμου και για ουσιαστικά, να γίνει και πιο ποιοτική δουλειά’.* (Μαρία,35) Ενώ σε άλλη συνέντευξη αναφέρετε: *‘Επίσης ένα XEX, υποπτεύομαι ότι δεν φτάνει. Δεν έχω στατιστικά δεδομένα, υποθέτω ότι οι πιάτσες είναι πολλές περισσότερες, ο κόσμος που είναι εκεί έξω εκτεθειμένος πάρα πολύ πιο πολύς. Και βέβαια το πρόγραμμα του street work, κάνει πολύ σημαντική δουλειά αλλά νομίζω ότι οι ανάγκες είναι περισσότερες από αυτές που καλύπτουμε εμείς.’* (Στέφανος,47). Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία, παρουσιάζεται ως συμπέρασμα η προτίμηση των χρηστών, αλλά και άλλων ενδιαφερόμενων να επισκέπτονται πολλαπλές μικρότερες εγκαταστάσεις, αντί για μια μεγάλη, κεντρική εγκατάσταση ελεγχόμενης χρήσης.(Fortson & McCulloch,2018)

Οι εργαζόμενοι που αναφέρθηκαν στο κομμάτι της αύξησης του προσωπικού, επικεντρώθηκαν κυρίως στην πρόσληψη φύλακα, δηλαδή σε ζητήματα ασφάλειας, τα οποία αναφέρθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο. Έχει γίνει ξεκάθαρο, ότι αυτή τη στιγμή το Στέκι⁴⁶ δεν έχει επαρκές προσωπικό για να εξασφαλίσει τη φύλαξη του χώρου, του προσωπικού και των ωφελούμενων. Ενώ σε δεύτερο χρόνο αναφέρθηκαν αρκετοί στην ανάγκη αύξησης του ιατρικού προσωπικού και κυρίως την ύπαρξη ψυχιάτρου μονίμως στο χώρο. *‘να έχουμε περισσότερο προσωπικό ενδεχομένως, γιατρούς περισσότερους που θα χρειάζοντουσαν ανάλογα την περίπτωση και βέβαια ψυχιατρικές εκτιμήσεις ή ακόμα και φύλακες. Όλα αυτά είναι στο πρόγραμμα τα οποία θα μπορούσαν να, σε αριθμό, ποσοτικά άμα ήταν περισσότερα, να βοηθήσουν περισσότερο.’* (Στέφανος,47) Αναγνωρίζοντας την ασταθή ψυχολογική κατάσταση των περισσότερων ατόμων που κάνουν χρήση, και κάνοντας αναφορά στα υψηλά ποσοστά συννοσηρότητας που υπάρχει στο πληθυσμό, όλοι οι εργαζόμενοι ζητούν την ύπαρξη ψυχιατρικής υποστήριξης και επίβλεψης στα πλαίσια του χώρου εποπτευόμενης χρήσης. *‘Και η παρουσία σε καθημερινή βάση και σε κάθε βάρδια και*

ψυχιάτρου... ώστε να.. ρυθμιστούν άνθρωποι που είναι πολύ καιρό σε αυτή τη κατάσταση και.. με ανοιχτές ψυχώσεις και κάνουν και χρήση και όλο αυτό είναι πολύ λάθος, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα, αν δεν πιαστείς και από το ιατρικό δηλαδή κομμάτι'(Δήμητρα,29)

Φαίνεται επίσης, ότι ο ίδιος ο χώρος του Στεκιού λειτουργεί περιοριστικά για τη λειτουργία του και την ασφάλεια προσωπικού και μελών. Ο χώρος Στέκι46, χωρίζεται από το πεζοδρόμιο με μια αυτοματοποιημένη πόρτα η οποία παραμένει διαρκώς ανοιχτή, και ο χώρος ασφαλούς χρήσης είναι ορατός από το δρόμο. Από τις συζητήσεις με το προσωπικό, προέκυψε ότι θα ήταν πρακτικό να υπάρξει προθάλαμος, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος στο ποιός μπαίνει και βγαίνει από τη δομή, ενώ παράλληλα θα ήταν πιο ασφαλές για όλους, καθώς θα μπορούν να αποτρέψουν την είσοδο σε άτομα που κρίνουν ως επικίνδυνα ή ακατάλληλα.

Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει είναι αυτό των διασυνδέσεων. Αναφέρθηκε και νωρίτερα στους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν στην διεκπεραίωση της δουλειάς τους, ότι δεν υπάρχει επαρκής διασύνδεση με άλλους φορείς όπως νοσοκομεία, ψυχιατρεία κτλ. Η ενίσχυση επομένως και των υπόλοιπων δομών που εργάζονται πάνω στην αντιμετώπιση των ναρκωτικών, αλλά και του δημόσιου συστήματος υγείας, θα συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία του δικτύου αλλά και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της κάθε δομής ξεχωριστά. 'Χρειάζονται συνε...συνεργασίες πιο σταθερές και να εξελίσσονται αυτές οι συνεργασίες. Και εντός οργανισμού και εκτός οργανισμού. Stay holders, σταθεροί που να εξελίσσεται αυτή η συνεργασία. (Γιώργος,45) Πιο ειδικά, και πάλι κάποια άτομα επικεντρώθηκαν στα ψυχιατρικά ζητήματα, αναδεικνύοντας για ακόμα μια φορά τα ζητήματα συννοσηρότητας. 'Τώρα καλύτερα θα ήταν η διασύνδεση με ψυχιατρεία θεωρώ γιατί πέρα από τους κάνει μια σταθεροποίηση δύο τρία χρόνια μετά τους διώχνουνε δηλαδή... έπρεπε να είναι λίγο πιο συντονισμένη η διασύνδεση με το... με τα ψυχιατρεία πιο πολύ όχι τόσο με τα νοσοκομεία, αλλά πιο πολύ με τα ψυχιατρεία γιατί έχουν πάρα πολλά θέματα δηλαδή' (Μαρία,35) Η υποβάθμιση γενικότερα των δημόσιων δομών, αντανακλάει και στην διεκπεραίωση του έργου στο χώρο εποπτευόμενης χρήσης. Καθώς, όταν ένας χρήστης χρειάζεται άμεση νοσηλεία ή καταθέτει αίτημα να ενταχθεί σε ένα ξενώνα θα πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημα του σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μια από τις πρώτες και βασικές αρχές της αντιμετώπισης των ναρκωτικών

είναι η προσβασιμότητα, η εύκολη και ανοιχτή πρόσβαση στις υπηρεσίες, χωρίς μεγάλο χρόνο αναμονής. (Παπαρρηγόπουλος & Δάλλα, 2021) Παρόλο που ο κανόνας αυτός προκύπτει για τα προγράμματα θεραπείας το ίδιο πρέπει να ισχύει και στην μείωση βλάβης, καθώς ο κόσμος που ζει στο δρόμο δεν έχει ούτε τη πειθαρχία ούτε τη πολυτέλεια, πολλές φορές να περιμένει.

Στο επίπεδο παρέμβασης στο πληθυσμό, αναδείχθηκαν ερωτήματα κυρίως από το ψυχοκοινωνικό προσωπικό, σε σχέση με την αποτελεσματικότερη παρέμβαση. Σε μια από τις συνεντεύξεις προτάθηκε η δημιουργία ομάδων ώστε να μπορούν να εντάξουν τους ωφελούμενους σταδιακά σε ένα ορισμένο πλαίσιο εκτός από αυτό της χρήσης. *‘Μικρές ομάδες, εντάζει αυτά γίνονται... στο Ιδάνω κτλ γίνονται ομάδες. Εδώ μπορούμε να γίνουμε μια πιο ανάλαφρη μορφή. Στην αυλή ναι μεν, να έχει ένα φιλοπλάνιο, γιατί δεν μπορείς να τους πλαισιώσεις και τελείως τον ενεργό χρήστη εντάζει... χωρίς να έχει ένα κίνητρο να μπει κάπου ή κάτι να αλλάζει. Αλλά σιγά σιγά... να υπήρχε μια.. ψυχοθεραπευτική δουλίτσα τέτοια... και... ένα άλλο προσωπικό, θέλει ένα άλλο προσωπικό να αναλάβει τα... εφόσον θέλουν να τα έχουν τα κοινωνικό-προνοιακά, επιδόματα, εξετάσεις... δεν μπορούν όλοι να τα κάνουν όλα δεν γίνεται. (Ελένη, 27)* Αυτή η πρόταση κατατέθηκε στο πλαίσιο να δημιουργηθούν και άλλα βήματα στα οποία κάποιος ενεργός χρήστης μπορεί να κινηθεί ώστε να ενταχθεί μελλοντικά σε κάποιο πρόγραμμα απεξάρτησης, να ενισχυθεί δηλαδή η διαδικασία της διασύνδεσης.

Τέλος, διατυπώθηκε και η ανάγκη να υπάρξει ποσοτική αποτύπωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στο χώρο εποπτευόμενης χρήσης, με γνώμονα την ικανοποίηση των χρηστών. *‘Χρειάζεται να μετράμε, να λαμβάνουμε υπόψη και τη γνώμη του ίδιου του ωφελούμενου. Και τη γνώμη του ίδιου του ωφελούμενου. Και επίσης χρειάζεται να μετράμε και την ικανοποίηση του από τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Και εκεί βάζω πολλά ερωτηματικά, του τι γίνεται σήμερα. Όχι, δεν μιλάει για την υπηρεσία. Γενικά για το σύστημά μιλάω. Κατά πόσο λαμβάνει το σύστημα τη γνώμη, την ευχαρίστηση του ωφελούμενου. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι από τα σημαντικά που πρέπει να μας απασχολούν ως επαγγελματίες’.* (Γιώργος,45)

Συνθήκες εργασίας.

Αναφέραμε μέχρι στιγμής κάποιες από τις προτάσεις των εργαζομένων για να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια της μείωσης της βλάβης στο Στέκι 46, αν και όλες οι προτάσεις που έγινε αφορούν ταυτόχρονα και τις συνθήκες στις οποίες καλείται το προσωπικό να ανταπεξέλθει. Έχοντας σαν δεδομένο ότι ένα προσωπικό που εργάζεται σε ικανοποιητικό περιβάλλον ανταπεξέρχεται και πιο αποτελεσματικά στις απαιτήσεις που προκύπτουν, θα πρέπει να εξετάσουμε και τις παρατηρήσεις που έγιναν σε αυτά τα πλαίσια.

‘Χρειάζεται να υπάρχει μια καλή επικοινωνία του προσωπικού μεταξύ του... και του προσωπικού με τους προϊστάμενους. Και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Να μοιραζόμαστε όλα όσο συμβαίνουν στα πλαίσια της δουλειάς μας. Και σε επίπεδο φόρτισης, αλλά και σε επίπεδο στο να δημιουργούνται κάποιοι στόχοι. Και οι στόχοι με τη πάροδο του χρόνου διαφοροποιούνται που αφορά τη δουλεία μας. εννοώ με τους ωφελούμενους έτσι [...]Και χρειάζεται και εποπτεία. εποπτεία εκτός οργανισμού να υπάρχει αντικειμενικότητα’ (Γιώργος, 45). Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέραμε το πώς η έλλειψη εποπτείας και τακτικών ομαδικών συναντήσεων λειτουργεί επιβαρυντικά για τους εργαζόμενους σε ατομικό επίπεδο. Ένας εξωτερικός παρατηρητής, όπως ο επόπτης μπορεί να πάρει θέση και να φέρει οπτικές που ένας εργαζόμενος μέσα στο πεδίο δράσης καμιά φορά αδυνατεί να σκεφτεί. Επίσης η εποπτεία μπορεί να μοιραστεί τις ευθύνες και το βάρος που φέρει η εργασία σε ένα χώρο εποπτευόμενης χρήσης. Επομένως, προκύπτει ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτό το δεδομένο, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των εργαζόμενων, το οποίο κατά συνέπεια θα μειώσει το εργασιακό στρες και θα βοηθήσει στην ομαλή λειτουργία του κέντρου. Παράλληλα, θα πρέπει να δοθούν εργαλεία μέσα από τη εκπαίδευση των εργαζομένων, στο να μπορούν να διαχειριστούν καταστάσεις που προκύπτουν στα πλαίσια της δουλειάς σε έναν χώρο εποπτευόμενης χρήσης. Αντί να θεωρείτε δεδομένο δηλαδή, το burnout , όπως ισχύει μέχρι σήμερα, θα πρέπει να υπάρξει πρόληψη για την εργασιακή κόπωση και αν ληφθούν μέτρα προστασίας και φροντίδας του προσωπικού. *‘Η φροντίδα του προσωπικού, είναι πρώτο βασικά αυτό και μετά τα υπόλοιπα. Η φροντίδα του προσωπικού. ε... και σίγουρα οι εκπαιδεύσεις που πρέπει να γίνονται παράλληλα. Δεν υπάρχει αυτό.’ (Δήμητρα,29)*

Συμπεράσματα

Η έρευνα αυτή είχε ως στόχο να αποκτήσουμε μια εις βάθος κατανόηση των συνθηκών υπό τις οποίες καλείται να λειτουργήσει το επιστημονικό προσωπικό, στην προσπάθεια του να παρέχει υποστήριξη στους χρήστες ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν και των περιορισμών που επιβάλλονται από το πλαίσιο. Επιπλέον, επιχείρησε να καταγράψει τους τρόπους με τους οποίους παρεμβαίνει η συγκεκριμένη δομή μέσα στο υπάρχον κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της Ελλάδας, εφαρμόζοντας τις πολιτικές μείωσης της βλάβης. Έγινε στα πλαίσια αυτά μια προσπάθεια να χαρτογραφηθεί η συμβολή ενός χώρου ελεγχόμενης χρήσης στον πληθυσμό των εξαρτημένων και στον δημόσιο χώρο της πόλης.

Μέσα από τις συνεντεύξεις, προέκυψαν ορισμένες θεματικές οι οποίες απαντάνε στα ερευνητικά ερωτήματα του τέθηκαν στην κατάθεση πρωτοκόλλου. Τα κεφάλαια αυτής της έρευνας δομούνται βάση αυτών των θεματικών. Αρχικά, παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι υπηρεσίες, οι διαδικασίες και ο καθημερινός τρόπος λειτουργίας του Στεκιού 46, αναλύοντας τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν στο πλαίσιο της Αθήνας. Παρατηρείται τα τελευταία χρόνια ραγδαία αύξηση του πληθυσμού των αστέγων και αντίστοιχα, των ατόμων που κάνουν χρήση ουσιών. Η λειτουργία του χώρου εποπτευόμενης χρήσης, φαίνεται να έχει σημαντική απήχηση στον πληθυσμό αυτό, ο οποίος στερείται φροντίδας. Ο συστηματικός αποκλεισμός των ναρκομανών από το δημόσιο σύστημα υγείας και ο στιγματισμός τους, οδηγεί στην επιπλέον περιθωριοποίηση τους από υπηρεσίες που είναι καθημερινά απαραίτητες. Η ύπαρξη του χώρου και η υποστήριξη του προσωπικού λύνει τα χέρια σε πολλές περιπτώσεις στα άτομα που απευθύνονται σε αυτούς για ζητήματα υγείας, επιδομάτων, εύρεση εγγράφων κτλ. Στο πρώτο κεφάλαιο επομένως, αναδείχθηκε η αναγκαιότητα ύπαρξης και οι τρόποι με τους οποίους υποστηρίζει ο χώρος εποπτευόμενης χρήσης στην Αθήνα τους λήπτες ουσιών.

Η δεύτερη θεματική που αποτελεί και το δεύτερο κεφάλαιο αυτής της έρευνας, είναι οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν στην υλοποίηση του έργου τους η δομή και το προσωπικό. Σε αυτή την ενότητα προέκυψαν διάφοροι παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά στην διεκπεραίωση των υπηρεσιών στα πλαίσια του χώρου εποπτευόμενης χρήσης, έτσι δημιουργήθηκαν τρεις υποενότητες. Το γεγονός αυτό ήταν αποτέλεσμα των συνεντεύξεων, καθώς, παρόλο που όλοι είχαν κοινές αφηγήσεις για τα προβλήματα που προκύπτουν στα πλαίσια της δομής, ο καθένας και η καθεμία συνεντευξιζόμενοι έδωσε έμφαση σε διαφορετικά θέματα. Έτσι, αναδείχθηκαν κάποια θέματα που προκύπτουν από την οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας, όπως είναι η ελλείψεις σε υλικά και προσωπικό, εστιάζοντας στην ασφάλεια του χώρου, η αδυναμία στις διασυνδέσεις καθώς και τα προβλήματα που προκύπτουν με τη γειτονιά. Πολλοί περιορισμοί της δράσης του χώρου εποπτευόμενης χρήσης προκύπτουν μέσα από την ίδια την οργάνωση, πάνω σε αυτά τα ζητήματα εστίασε η δεύτερη υποενότητα του κεφαλαίου δύο. Τα ζητήματα αυτά είναι κυρίως οργανωτικά, θέματα που προκύπτουν από την ανεπαρκή επικοινωνία των ατόμων που αποτελούν το προσωπικό, που οδηγεί συχνά στην έλλειψη ομαδικότητας αλλά και στην συνεννόηση και συνεργασία με τη διοίκηση της δομής. Όλα αυτά περιγράφηκαν από τους συνεντευξιζόμενους με τον όρο πιάτσα πολυτελείας, ο οποίος περιγράφει κάπως κυνικά την έλλειψη οργάνωσης και κοινής γραμμής. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται συχνά από τους εργαζόμενους και τους ωφελούμενους και αναφέρθηκε αρκετά στις συνεντεύξεις. Η τελευταία αλλά εξίσου σημαντική θεματική που προέκυψε αφορά την εργασιακή κόπωση (burnout). Τα δύο προηγούμενα υποκεφάλαια συμβάλουν στην συσσώρευση στρες και κούρασης για το προσωπικό. Στην κατάσταση αυτή συμβάλει και η ματαιότητα που προκύπτει από το αντικείμενο εργασίας τους, η έλλειψη αισθήματος φροντίδας από τη διοίκηση της δομής, η έλλειψη φύλαξης και ομαδικότητας καθώς και η απουσία τακτικών ομάδων και εποπτείας. Η κόπωση των εργαζομένων αποτελεί ένα ζωτικό περιορισμό για την αποτελεσματική λειτουργία της δομής. Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες που παρέχει έχουν κυρίως να κάνουν με επικοινωνία και αλληλεπίδραση, η έλλειψη οράματος και ενέργειας του προσωπικού λειτουργεί ανασταλτικά στην εξυπηρέτηση των ωφελούμενων αλλά και στη δέσμευσή τους σε κάποια συνεδρία ή θεραπεία.

Το Τελευταίο κεφάλαιο που προέκυψε, και επομένως η τελευταία θεματική, είναι οι προτάσεις των εργαζομένων για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν και των συνθηκών μέσα στις οποίες εργάζονται. Αρχικά, αρκετά μέλη του προσωπικού πρότειναν την λειτουργία περισσότερων χώρων εποπτευόμενης χρήσης στην Αθήνα. Επίσης, αρκετές ήταν οι αναφορές στην ανάγκη πρόσληψης περισσότερων φυλάκων, καθώς και ψυχιάτρων. Πάνω σε αυτή τη θεματική αναφέρθηκε και η ανάγκη ενίσχυσης των διασυνδέσεων και η καλύτερη λειτουργία των δομών με τις οποίες συνεργάζεται το Στέκι 46 (πχ. Δημόσιο σύστημα υγείας) καθώς και η καλύτερη διαμόρφωση του χώρου εποπτευόμενης χρήσης. Τέλος, σε επίπεδο βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, κρίθηκε απαραίτητο η διασφάλιση ομάδων και εξωτερικής εποπτείας του έργου τους κάτι που θα ενισχύσει την επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού και θα συμβάλει στην βελτίωση των πρακτικών αναδεικνύοντας τους στόχους της ομάδας.

Συνολικά, μέσα από τις συνεντεύξεις αναδεικνύεται μια κατάσταση, η οποία επικρατεί στην πλειονότητα των δομών και αντανακλά την γενική εικόνα που παρουσιάζεται στις υπηρεσίες της Ελλάδας. Παρόλο που το Στέκι 46, παράγει σημαντικό έργο, το οποίο γίνεται αντιληπτό και από τα λεγόμενα των συμμετεχόντων στην έρευνα και από την προσέλευση του κόσμου για χρήση των υπηρεσιών, αντιμετωπίζει διαρκώς περιορισμούς από την οργάνωση του χώρου και τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Πολλά από τα ζητήματα που αναφερθήκαν παραπάνω, θα μπορούσαν να επιλυθούν άμεσα ενώ άλλα απαιτούν οικονομικούς πόρους και ριζικές αλλαγές του δημόσιου συστήματος υγείας.

Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι στη βιβλιογραφία γίνονται συνεχώς αναφορές στις ανάγκες για δίκτυο δομών που εξυπηρετούν τις ανάγκες των εξαρτημένων ατόμων. Στο βιβλίο του Κ. Γαζγαλίδη αναφέρεται: 'Στο πλαίσιο ενός πλουραλιστικού θεραπευτικού μοντέλου, τα προγράμματα μείωσης της βλάβης και αποχής οφείλουν να συνεργάζονται, εν είδει συγκοινωνούντων δοχείων, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες όσο γίνεται περισσότερων χρηστών. (Γαζγαλίδης, 2005) Στο παράδειγμα του Στεκιού 46, η συνεργασία αυτή φαίνεται να λειτουργεί, έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμες παραπομπές μέσα στο μικρό χρονικό διάστημα που λειτουργεί ο χώρος. Ωστόσο, το δίκτυο δομών θα πρέπει να ενισχυθεί, καθώς ο περιορισμός των θέσεων

και η συνεχής αύξηση του πληθυσμού που κάνει χρήση ουσιών, δημιουργεί ζήτημα ως προς την έγκαιρη ικανοποίηση των αναγκών των ωφελούμενων. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα στη θεραπεία σε όλα τα υποκείμενα που κάνουν χρήση ανεξαρτήτως προσωπικών και κοινωνικών παραγόντων. (Παπαρηγόπουλος & Δάλλα, 2021) Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για προγράμματα και δράσεις που συμβάλουν στη μείωση της βλάβης, που προέρχεται από τα ναρκωτικά και σε ατομικό και σε κοινωνικό επίπεδο, θα πρέπει να ενισχυθεί το σύνολο των δομών που συνεργάζεται σε αυτή τη βάση.

Ιδιαίτερη έμφαση ωστόσο θα πρέπει να δοθεί στη συνεργασία με τους φορείς δημόσιας υγείας. Το εθνικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα, αντιμετωπίζει σοβαρές δυσλειτουργίες, που οδηγούν στην συνεχή υποβάθμιση του. Το γεγονός αυτό, αποτυπώνεται στην καθημερινότητα του γενικού πληθυσμού, ενώ συγκεκριμένα στον κύκλο των εξαρτημένων τα ελλείμματα γίνονται ακόμα πιο εμφανή καθώς οι ανάγκες τους για ιατρικό-νοσηλευτική φροντίδα είναι μεγαλύτερες. Αρχικά, ο μειωμένος αριθμός ασθενοφόρων και ο φόρτος εργασίας του ιατρικού προσωπικού δημιουργούν δυσκολία να ανταποκριθούν άμεσα και έγκαιρα σε καταστάσεις επειγόντων περιστατικών, ενώ ο κοινωνικός στιγματισμός και τα στερεότυπα που συνδέονται με τη χρήση ουσιών, οδηγεί στον αποκλεισμό των χρηστών από τα νοσοκομεία. Προκειμένου, το έργο των προγραμμάτων μείωσης βλάβης να μπορέσει να αναβαθμιστεί και να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά, θα πρέπει παράλληλα μειωθεί η περιθωριοποίηση και ο στιγματισμός των εξαρτημένων, ειδικά στα ζητήματα που αφορούν τη φροντίδα της υγείας τους. Περιορισμοί επίσης, δημιουργούνται στη διεκπεραίωση του έργου του Στέκι 46, από την στάση της ελληνικής αστυνομίας. Όπως και στο σύστημα υγείας, έτσι και στα σώματα της αστυνομίας ο στιγματισμός των χρηστών είναι κανονικότητα, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα όταν υπάρχει ανάγκη να παρέμβουν, κάτι που συμβαίνει συχνά λόγω της παράνομης φύσης των ναρκωτικών και των παραβατικών συμπεριφορών που προκύπτουν από τη χρήση τους. Οι χρήστες συνήθως αποφεύγουν την εμπλοκή με τα μέλη της αστυνομίας, ενώ οι τελευταίοι αντιμετωπίζουν τους χρήστες σαν επικινδύνους. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις θα μπορούσαν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά για τις δομές που εργάζονται πάνω στην μείωση της βλάβης. Τέτοια παραδείγματα παρουσιάζονται σε χώρους εποπτευόμενης χρήσης του εξωτερικού, όπου η αστυνομία στηρίζει το έργο

των χώρων παραπέμποντας τους χρήστες σε αυτούς και διασφαλίζοντας την αποφυγή βίαιων περιστατικών στη δομή με συνεχή ή τακτική παρουσία έξω από το χώρο. Είναι αναγκαιότητα επομένως, να αναβαθμιστούν οι κρατικές δομές, σε σχέση με την διαχείριση και αντιμετώπιση των ναρκωτικών, ώστε να ξεπεραστεί ο κοινωνικός στιγματισμός, αλλά και να διευκολύνει το έργο των δομών που δουλεύουν πάνω στον κλάδο. Με αυτόν τον τρόπο η κάθε επιμέρους δομή θα καλύπτει μια ανάγκη ή μια υπηρεσία και δεν θα χρειάζεται αυτές που παρεμβαίνουν στην πρώτη γραμμή, όπως είναι το Στέκι 46, να αναλαμβάνει αρμοδιότητες εκτός των καθηκόντων του.

Έμφαση επίσης θα πρέπει να δοθεί στις εργασιακές συνθήκες του προσωπικού. Μέσα από την έρευνα αποτυπώθηκαν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, τα οποία δυστυχώς, με διαφοροποιήσεις ανάλογα τη δομή, εμφανίζονται γενικότερα στο χώρο της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Είναι αναγκαίο επομένως, να αναδειχθεί και να αντιμετωπιστεί η εργασιακή κόπωση (burnout) που βιώνουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο, ως ζήτημα προς επίλυση και όχι σαν δεδομένη συνθήκη εργασίας στον κλάδο. Θα πρέπει ίσως σε αυτό το σημείο, να γίνει μια διαφοροποίηση της ματαιότητας που προκύπτει από το αντικείμενο της δουλειάς τους, που έχει να κάνει με την αλληλεπίδραση με ανθρώπους που επαναλαμβάνουν συνεχώς βλαβερά μοτίβα για τους ίδιους και δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγές στην ζωή τους, και στην ματαιότητα και τη κόπωση που προκύπτει από την έλλειψη κινήτρου, ασφάλειας και οράματος. Η πρώτη μορφή δυστυχώς είναι δεδομένη στους επαγγελματίες που ασχολούνται με την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, η δεύτερη μορφή εξάντλησης όμως μπορεί να αντιμετωπιστεί, αν παρθούν μέτρα από τη διοίκηση της δομής, που θα στοχεύουν στην φροντίδα των εργαζομένων. Σε μια κατάσταση επομένως, που οι επαγγελματίες εργάζονται για να βοηθήσουν και να διεκπεραιώσουν τα αιτήματα των ωφελομένων, βρίσκονται εν τέλει οι ίδιοι σε μια θέση να χρειάζονται υποστήριξη και φροντίδα. Οι συνεντευξιαζόμενοι –ες, παρουσίασαν πολλές προτάσεις και σκέψεις για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης και είναι ανάγκη να ληφθούν μέτρα ώστε να περιοριστεί η ματαίωση και το αίσθημα διαρκούς εξάντλησης.

Στα πλαίσια των συνεντεύξεων έγινε προσπάθεια να τεθούν ερωτήματα που θα αναδεικνύουν το όραμα του επιστημονικού προσωπικού τόσο για το μέλλον της

δομής, αλλά και γενικότερα για τις πολιτικές μείωσης βλάβης αλλά και μια κριτική για τις υπάρχουσες αντιφάσεις του χώρου. Ωστόσο, δεν έγινε εφικτό να αποτυπωθεί κάποια κριτική ούτε προς την κοινωνία ούτε προς τις πολιτικές που εφαρμόζονται, πέρα από την έλλειψη οικονομικών πόρων. Η αδυναμία αποτύπωσης αυτών των σκέψεων, αιτιολογείται από την απουσία νοήματος στα πλαίσια της δουλείας των συνεντευξιαζόμενων, το έντονο αίσθημα ματαίωσης και εργασιακής κόπωσης που τους οδήγησε να επικεντρωθούν στα συντεχνιακά προβλήματα του χώρου στα πλαίσια των συνεντεύξεων. Χωρίς να μειωθεί η σημασία αυτών, θα ήθελα να σχολιάσω την σημασία ύπαρξης οράματος και νοήματος για τους εργαζόμενους στο κλάδο αντιμετώπισης των ναρκωτικών. Είτε αυτή η κατάσταση προκύπτει από την εργασιακή κόπωση είτε είναι αποτέλεσμα μια κοινωνικής κατάστασης, είναι εμφανές ότι επηρεάζει και περιορίζει τις δυνατότητες αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν επιτρέπει την διεύρυνση του επιστημονικού διαλόγου που διεξάγεται στους κλάδους που ασχολούνται με την αντιμετώπιση των ναρκωτικών ουσιών.

Μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα, η οποία επικεντρώνεται στο να δια φωτίσει τη λειτουργία του χώρου εποπτευόμενης χρήσης, αναδεικνύονται ζητήματα που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, όπως είναι ο στιγματισμός της χρήσης, η υποχρηματοδότηση των δημόσιων δομών, οι εργασιακές συνθήκες στην Ελλάδα κ.α. Η κατάσταση κρίσης, στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, (οικονομική κρίση, κορονοϊός, μεταναστευτική κρίση, πληθωρισμός) έχει συμβάλει στην αύξηση του πληθυσμού των αστέγων και κατ' επέκταση και των ληπτών ουσιών. Επιπρόσθετα, η επιδείνωση της ποιότητας ζωής στη χώρα, αποτυπώνεται στο σύνολο των υπηρεσιών, επηρεάζοντας και τους εργαζόμενους που τις στελεχώνουν καθώς και τον εξαρτημένων πληθυσμό. Συμπερασματικά, για μια ακόμα φορά αναδεικνύεται η ανάγκη να υπάρξει εκπαίδευση και ενημέρωση του γενικού πληθυσμού σε σχέση με τα ναρκωτικά. Αρχικά, για λόγους πρόληψης, καθώς στην σύγχρονη εποχή οι παράγοντες που αναφέραμε παραπάνω συμβάλουν στη χρήση ουσιών στο γενικό πληθυσμό, αλλά επίσης για να ξεπεραστεί ο στιγματισμός των χρηστών, που κάνει την ζωή τους στη χρήση ακόμα πιο δύσκολη, αποκλείοντας τους από υπηρεσίες και περιθωριοποιώντας τους επιπλέον. Θα πρέπει επομένως, να χαραχτούν πολιτικές που θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των ναρκωτικών ολιστικά,

στην πολυπλοκότητα του, ακολουθώντας μια λογική που θα εξυπηρετεί το σύνολο των πολιτών και της δημόσιας υγείας, ενισχύοντας την πρόληψη, τη θεραπεία, την επανένταξη αλλά και τη μείωση της βλάβης που προκαλείται από τη χρήση ναρκωτικών.

Υπόμνημα – Συντομογραφίες

ΧΕΧ = Χώρος Εποπτευόμενης Χρήσης

ΣΦΕΑ = Σταθμός Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων

ΤΕΠ = Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Βιβλιογραφία

- Γαζγαλίδης Κ, *Ναρκωτικά: εγχειρίδιο για τη μείωση της βλάβης*, 2005, Προσεγγίσεις, Εξάντας
- Μάτσα Κ., *Ψάξαμε για ανθρώπους και βρήκαμε σκιές, το αίνιγμα της τοξικομανίας*, 2011, Εκδόσεις Άργα
- Μάτσα Κ., *Ψυχοθεραπεία και Τέχνη στην Απεξάρτηση, Το παράδειγμα του Ιδάνω*, 2006, Εκδόσεις Άργα.
- Παπαδημητρίου, Δημήτρης, *Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης σε Πληθυσμό Χρηστών Ναρκωτικών Ουσιών που Προσεγγίζουν το ΚΕΘΕΑ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρική Σχολή-Νοσηλευτική Σχολή, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων*, Αθήνα, 2014
- Παπαρρηγόπουλος Θ, *Δάλλα Χρ, Οι εξαρτήσεις, αίτια, μηχανισμοί, εκδηλώσεις, αντιμετώπιση*, 2021, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.
- Παρασκευόπουλος Ν., *Η καταστολή της διάδοσης των ναρκωτικών στην Ελλάδα*, 2004, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη
- Τζίνη, Δ. (2018-2019), *Οικονομική Κρίση και Ναρκωτικά, Οι επιπτώσεις και οι πολιτικές για τα ναρκωτικά*, Μυτιλήνη, Πτυχιακή Εργασία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας.
- Τσιώλης, Γ, *Θεματική ανάλυση ποιοτικών δεδομένων*, 2017, εκδόσεις ελληνικό
- Τσιώλης, Γ. *Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα*, 2014, Αθήνα Κριτική.

Πηγές από το διαδίκτυο:

- EMCDDA, *Drug consumption rooms: an overview of provision and evidence*. Lisbon: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2018. Ανακτήθηκε από [:https://www.emcdda.europa.eu/publications/pods/drug-consumption-rooms_en](https://www.emcdda.europa.eu/publications/pods/drug-consumption-rooms_en)

- *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2023), European Drug Report 2023: Trends and Developments, https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023_en*
- *Fortson, R. McCulloch, L. Evidence and Issues Concerning Drug Consumption Rooms, May 21, 2018, Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper No. 279/2018, Ανακτήθηκε από SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3182568>*